



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

LAPORAN KEGIATAN

**KOMITE MUTU
RS. PRIMA HUSADA
SUKOREJO**

**TRIWULAN IV
TAHUN 2023**

LEMBAR DISPOSISI DIREKTUR

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN KEGIATAN KOMITE MUTU DESEMBER RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO TAHUN 2023

Dalam pembangunan sektor kesehatan, salah satu prakondisi yang harus dipenuhi adalah meningkatkan mutu pelayanan, termasuk mutu pelayanan di rumah sakit agar pengelolaan rumah sakit menjadi lebih efektif dan efisien. Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit prima Husada Sukorejo disusun berdasarkan program kerja yang telah disepakati bersama oleh direktur dan seluruh stake holder yang terlibat dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan nantinya diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Disusun Oleh :

Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo

Malang, 31 Desember 2023

Telah Disetujui Oleh :

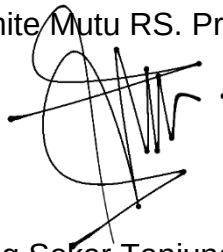
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika

(Endang Susilowati)

LEMBAR PENGESAHAN
Laporan Kegiatan Komite Mutu Bulan Desember Tahun 2023
Rumah Sakit Prima Husada

Laporan Kegiatan Komite Mutu RS. Prima Husada digunakan sebagai bahan acuan di unit kerja untuk menjalankan Rencana perbaikan kinerja maupun layanan di unit Kerja Rumah Sakit Prima Husada

Disusun,
Oleh ;
Ketua Komite Mutu RS. Prima Husada



(Bening Sekar Tanjung, SKM)

Disetujui oleh,
Authorized Person



(Dr.dr.Aslichah M.Kes., AFP)

Disetujui,
Oleh

Direktur RS. Prima Husada



(dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, SWT karena atas Rahmat-Nya Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Desember Tahun 2023 telah dapat diselesaikan. Laporan ini berisikan kumpulan dari program kegiatan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang menjangkau keseluruhan unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Untuk melaksanakan program tersebut tidaklah mudah karena memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kepala bidang/bagian, keperawatan, penunjang medis, administrasi dan lainnya termasuk kepala unit / instalasi pelayanan.

Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Desember Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada Tahun 2024.

Akhir kata, kami dari Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya seluruh program dari Komite Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sehingga tersusunnya laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Tahun 2023. Semoga dengan adanya laporan ini kita dapat meningkatkan mutu layanan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

Penyusun

Komite Mutu

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN..... ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI v

BAB I15

PENDAHULUAN.....15

1.2 Tujuan.....15

1.2.1 Tujuan Umum.....15

1.2.2 Tujuan Khusus15

BAB II16

HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN PMKP16

DESEMBER TAHUN 202316

2.1 Kegiatan Pokok16

2.2 Kegiatan yang Dilakukan16

2.3 Jadwal Kegiatan.....17

2.4 Pencatatan dan Pelaporan17

BAB III18

HASIL KEGIATAN18

3.1 Pemantauan Indikator Mutu.....18

3.1.1 Indikator Mutu Nasional18

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional yang Tidak Di inginkan.....19

3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit.....26

3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit yang Tidak Di inginkan
27

3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit.....31

1. Instalasi Gawat Darurat31

2. Instalasi Rawat Inap 2A34

3. Instalasi Rawat Inap 2B37

4. Instalasi Rawat Inap 3.....40

5. Instalasi Care Unit.....45

6. Instalasi Kamar Operasi45

7. Maternitas.....47

8. Perinatologi.....47

9. Instalasi Rawat Jalan47

10. Instalasi Laboratorium47

11. Instalasi Radiologi.....48

12. Instalasi Rekam Medis48

13. Instalasi Gizi.....49

14. Rehabilitasi Medik49

15. Humas & Marketing50

16.	Keuangan	50
17.	Bagian SDM.....	50
18.	Kesekretariatan	51
19.	Rumah Tangga.....	51
20.	Kamar Jenazah	52
21.	Laundry.....	52
22.	IPSRS	52
23.	Instalasi SIMRS.....	52
24.	K3RS	52
25.	CSSD	53
26.	Komite PPI.....	53
27.	PKRS	53
28.	Tim HIV.....	54
29.	TB DOTS	54
30.	Verifikasi.....	54
31.	KB	55
32.	Stunting	55
33.	Ponek	55
BAB IV		56
HASIL MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM MUTU LAINNYA		56
4.1	Program Sasaran Keselamatan Pasien	56
4.1.1	Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi RS Prima Husada Sukorejo adalah menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi RS Prima Husada Sukorejo, maka ditetapkan tiga misi sebagai berikut : (1) memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat, (2) mengutamakan kepuasan pasien, (3) meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Untuk memberikan pelayanan dengan mengutamakan mutu, keselamatan dan kepuasan pasien RS Prima Husada Sukorejo melakukan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang sesuai dengan Standar Akreditasi Nasional. Kegiatan ini dilakukan di semua unit kerja untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit dan sebagai manajemen kontrol untuk mendukung pengambilan keputusan.

Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien RS Prima Husada Sukorejo pada tahun 2023 menetapkan indikator rumah sakit sesuai standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dari KARS STARKES berdasarkan standar PMKP 3, dapat diklasifikasikannya indikator rumah sakit sebagai berikut : Indikator nasional mutu, indikator mutu prioritas Rumah sakit (IMP-RS) yang meliputi : indikator sasaran keselamatan pasien, indikator pelayanan klinis prioritas, indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit, indikator terkait perbaikan sistem dan indikator terkait manajemen resiko, kemudian yang ketiga yakni insikator mutu prioritas unit.

Identifikasi prosedur, proses dan hasil dari kegiatan yang dinilai sebelumnya pada tahun 2023, disertai tujuan untuk menekan permasalahan yang ada di rumah sakit mendasari dipilihnya indikator baru di indikator prioritas. Kriteria pemilihan tetap didasarkan pada kasus yang memiliki volume tinggi, resiko tinggi atau biaya tinggi, disesuaikan dengan visi dan misi rumah sakit. Laporan Komite Mutu Desember Tahun 2023 indikator mutu yang diambil oleh unit kerja.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui mutu pelayanan dan penerapan keselamatan pasien di setiap unit di RS Prima Husada Sukorejo

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengevaluasi peningkatan mutu RS Prima Husada Sukorejo melalui pemantauan indikator mutu internal atau eksternal berdasarkan standar Komite Mutu Tahun 2023
2. Mengevaluasi program keselamatan pasien dengan pemantauan Insiden Keselamatan Pasien Rumah Sakit (IKP-RS)
3. Mengevaluasi pelaksanaan program mutu lain, yang dilakukan oleh unit terkait dengan peningkatan mutu yakni :
 - a. Program manajemen resiko
 - b. Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di unit kerja
4. Menganalisis capaian indikator mutu unit untuk mendapatkan bahan rekomendasi sebagai rencana tindak lanjut perbaikan di unit

BAB II
HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN PMKP
DESEMBER TAHUN 2023

2.1 Kegiatan Pokok

Seperti yang dijelaskan di atas, kegiatan pemantauan indikator mutu Komite Mutu Tahun 2023 yang dilaporkan adalah periode bulan Januari sampai Desember Tahun 2023. Adapun indikator mutu yang dipantau adalah sebagai berikut :

A) Indikator Mutu Nasional

1. Ketidakpatuhan Identifikasi Pasien
2. Waktu Tanggap operasi Seksio Sesarea Cito ≥ 30 menit
3. Waktu Tunggu Rawat Jalan ≥ 60 menit
4. Penundaan Operasi Elektif ≥ 60 menit
5. Ketidakpatuhan Jam Visite DSepter Spesialis $\geq$ jam 14.00
6. Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium ≥ 30 menit
7. Ketidakpatuhan Penggunaan Formularium Nasional
8. Ketidakpatuhan Cuci Tangan
9. Ketidakpatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh
10. Ketidakpatuhan Terhadap Clinical Pathway
11. Ketidakpuasan Pasien Dan Keluarga
12. Keterlambatan Respon Terhadap Komplain
13. Ketidakpatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Apd)

B) Indikator Mutu Prioritas

1. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
 - a. Kepatuhan identifikasi pasien IGD
 - b. Kepatuhan pengisian form SBAR oleh petugas IGD
 - c. Kejadian tidak adanya label high alert pada obat di IGD
 - d. Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi
 - e. Kepatuhan hand hygiene petugas IGD
 - f. Kepatuhan upaya pencegahan pasien IGD jatuh
2. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas
 - a. Angka kelengkapan asesmen awal medis pasien IGD
 - b. Waktu tanggap pelayanan gawat darurat pada pasien
3. Indikator Berdasarkan Renstra RS
 - a. Waktu tunggu di IGD sebelum masuk rawat Inap ≥ 3 jam (paien P2 & P3)
 - b. Kematian Pasien Di Instalasi Gawat Darurat ≤ 24 Jam
4. Indikator Perbaikan Sistem
 - a. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka
4. Indikator Manajemen Resiko
 - a. Angka tidak terpasangnya gelang identitas pasien IGD
4. Praktik Klinis yang Di Evaluasi
 - a. Diabetes Millitus
 - b. HIV
 - c. Hipertensi
 - d. TB
 - e. Keganasan
 - f. Fraktur terbuka
 - g. Stroke hemoragik
 - h. Stroke Trombosis

2.2 Kegiatan yang Dilakukan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu secara berkesinambungan
2. Melakukan analisis hasil capaian mutu indikator di unit kerja

-
3. Melakukan rencana tindak lanjut untuk perbaikan capaian atau mencapai target yang ditentukan
 4. Melakukan penyampaian hasil pemantauan indikator mutu di unit kerja
 5. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu

2.3 Jadwal Kegiatan

1. Melakukan pemantauan indikator mutu di unit kerja secara berkesinambungan
2. Melakukan tabulasi terhadap data hasil pemantauan indikator mutu (dilakukan setiap bulan)
3. Melakukan pelaporan hasil pemantauan indikator di unit kerja setiap bulan, serta menyusun program perbaikan mutu dengan teknik PDSA oleh penanggungjawab pengumpul data unit di koordinasikan dengan komite Mutu
4. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien rumah sakit setiap satu bulan.
5. Menyusun laporan hasil pemantauan indikator mutu dan keselamatan pasien RS. Prima Husada Sukorejo dengan hasil benchmarking perbandingan capaian mutu dengan RS lain setiap tiga bulan sekali

2.4 Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan oleh penanggungjawab data mutu unit, kemudian dilakukan rekapitulasi dan analisa oleh penanggungjawab. Data hasil pemantauan ditulis pada form laporan harian mutu dan dilakukan validasi kepada kepala unit untuk memastikan data yang dikumpulkan sudah benar dan valid. Jika data sudah valid selanjutnya akan dilakukan analisis data untuk mencari rencana tindak lanjut bagi indikator mutu yang masih belum mencapai target atau standar yang ditetapkan. Hasil pengolahan dan analisis data dituangkan dalam laporan tertulis kemudian akan dilaporkan kepada penanggungjawab mutu rumah sakit setiap bulan dalam rapat koordinasi mutu bulanan.

Penanggung jawab mutu Rumah Sakit selanjutnya akan menentukan langkah untuk membuat rencana tindak lanjut indikator mutu yang belum sesuai target sebagai bentuk feedback dari pelaporan penanggung jawab mutu di unit.

BAB III
HASIL KEGIATAN

3.1 Pemantauan Indikator Mutu

Berikut merupakan hasil pemantauan indikator mutu RS. Prima Husada Sukorejo yang dilakukan pada Bulan Januari - Desember Tahun 2023.

3.1.1 Indikator Mutu Nasional

Berikut merupakan penjelasan mengenai capaian indikator mutu nasional RS. Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2023.

Tabel 3.1 Indikator Mutu Nasional

No	Judul Indikator Mutu Nasional	Standar
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
2	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea emergency	100%
3	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥80%
4	Penundaan Operasi Elektif	≤5%
5	Ketpatuhan Waktu Visite DSepter	≥80%
6	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium	100%
7	Kepatuhan Penggunaan For-mularium Nasional	≥80%
8	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%
9	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	100%
10	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	≥80%
11	Kepuasan Pasien Dan Keluarga	≥76.61%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥80%
13	Ketidakpatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Apd)	100%

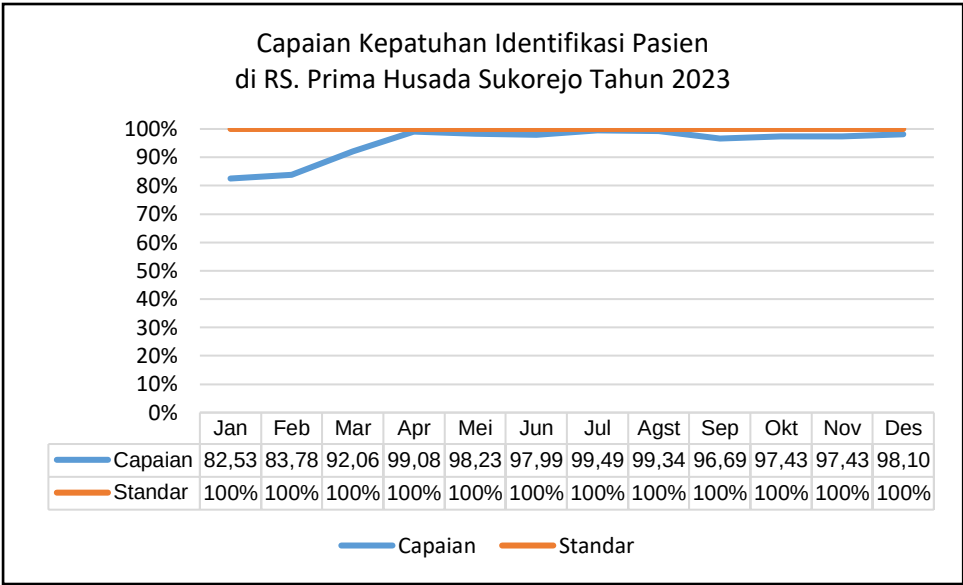
Tabel 3.2 Capaian Indikator Mutu Nasional RSPH Sukorejo Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Bulan												Std	Rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des			
1	Kepatuhan identifikasi pasien	82,53 %	83,78 %	92,06 %	99,08 %	98,23 %	97,99 %	99,4 9%	99,34 %	96,69%	97,43 %	97,43%	98,10%	100%	95,18%	Tidak tercapai
2	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea emergency	93%	88,09 %	88,37 %	89,28 %	88,70 %	88,46 %	90,9 6%	91,11 %	92,59%	93,75 %	91,11%	96,87%	≥80%	91%	tercapai
3	Waktu Tunggu Rawat Jalan	96,88 %	98,07 %	99,53 %	100 %	92,45 %	100 %	100 %	100%	98,75%	100%	100%	97,05%	≥80%	99,18%	tercapai
4	Penundaan Operasi Elektif	4,38 %	4,88 %	9,257 %	0,71 %	0,83 %	1,26 %	2,36 %	1,74 %	0,83%	4,41%	1,12%	1,53%	≤5%	2,4%	tercapai
5	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	90,93 %	92,23 %	91,62 %	87,21 %	92,70 %	87,90 %	89,3 8%	86,05 %	89,95%	85,19 %	64,31%	64,37%	≥80%	83,38%	tercapai
6	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	tercapai
7	Kepatuhan Penggunaan For-mularium Nasional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	≥80%	100%	tercapai
8	Kepatuhan Kebersihan Tangan	83,80 %	74,94 %	68,24 %	84%	70%	75%	77,0 8%	82%	78%	90%	78%	83%	≥85%	78,67%	Tidak tercapai
9	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	79,38 %	89,13 %	88,84 %	89,69 %	99,82 %	100 %	99,9 3%	99,79 %	98,95%	92,75 %	96,05%	96,25%	100%	94,21%	Tidak tercapai
10	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	66%	61%	62%	87,12 %	85,42 %	-	-	-	66%	93,47 %	90%	90,48%	≥80%	90,78%	tercapai
11	Kepuasan Pasien Dan Keluarga	80%	81,23 %	80,14 %	81,25 %	83,47 %	84,51 %	86,4 4%	77,50 %	78,57%	85,78 %	85,84%	89,54%	≥ 76,61%	82,85%	tercapai
12	Kecepatan Waktu	86%	86,41 %	86,54 %	82,14 %	83,15 %	82,44 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100Z%	≥80%	92,22%	tercapai

	Tanggap Komplain															
13	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Apd)	83%	84,41 %	85,36 %	85%	83%	90%	88%	96%	94%	69%	91%	88%	100%	87.81%	Tidak tercapai

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional yang Tidak Di inginkan

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di RS. Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2023 rata-rata mecapai 95,17%. dari 14 unit yang di observasi unit rawat inap 2A masih memiliki capaian dibawah standar.

Berikut merupakan rata-rata capaian untuk setiap unit :

1. IGD : 100%
2. Irna 2A : 73.38% dari 124 pasien yang di observasi ditemukan 33 pasien yang tidak dilakukan dengan benar pada saat memberikan obat kepada pasien, memberikan diet pada pasien.
3. Irna 2B : 100%
4. Irna 3A : 100%
5. Irna 3B : 100%
6. ICU : 100%
7. Maternitas : 100%
8. Perinatologi : 100%
9. Rawat Jalan : 100%
10. Laboratorium : 100%
11. Radiologi : 100%
13. Rehab Medik : 100%
14. Rehab medik : 100%

Tabel 3.4 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Tahun 2023

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Tahun 2023 adalah 95.18%, belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Rencana : mengetahui kepatuhan petugas melakukan identifikasi pasien secara berkesinambungan Harapan : seluruh petugas di unit pelayanan melakukan identifikasi pasien dengan benar menggunakan minimal 2 identitas dari 4 identitas yang dapat digunakan Tindakan : a. melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkesinambungan

	b. melakukan peneguran kepada staff jika masih melakukan proses identifikasi yang salah / tidak melakukan c. koordinasi dengan kepala ruang untuk lebih memantau kinerja dari staff yang tidak melakukan identifikasi dengan benar / tidak melakukan identifikasi d. koordinasi dengan komite sasaran keselamatan pasien untuk terus melakukan supervisi & sosialisasi terkait identifikasi pasien e. Menghimbau dan mengingatkan ke semua staff di unit pelayanan mengenai pentingnya melakukan identifikasi pasien untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi kepada pasien
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Cara mengidentifikasi petugas kepada pasien dengan menggunakan 2 identitas dari 4 identitas yang ditentukan (nama, tgl lahir, nomor RM dan gelang identitas) 2. Ketepatan waktu dilakukan identifikasi pasien (pemberian produk darah, obat, tindakan, pemeriksaan penunjang, diet)
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Cara mengidentifikasi petugas kepada pasien dengan menggunakan 2 identitas dari 4 identitas yang ditentukan (nama, tgl lahir, nomor RM dan gelang identitas) 2. Waktu dilakukan identifikasi pasien yakni sebelum pemberian obat, pengambilan darah atau specimen lain, pemeriksaan klinis pada pasien, pengobatan atau tindakan kepada pasien belum terkaji secara maksimal 3. Masih ditemukan ketidakpatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien di Rawat Inap 2A yang masih tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada tahun 2023 mencapai 97,43%, grafik tren capaian menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pada bulan januari sampai bulan April. Kemudian di bulan juni terjadi penurunan capaian disebabkan oleh kurangnya tersupervisi masing-masing unit. Setelah dilakukan sosialisasi terjadi peningkatan dari bulan September sampai bulan desember 2. Mayoritas petugas masih belum mengetahui kapan waktu yang di anjurkan untuk melakukan identifikasi pasien Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Evaluasi pencapaian pada Bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin. 2. Dilakukan pembentukan kelas-kelas kecil untuk unit yang belum mencapai target sasaran untuk peningkatan pengetahuan petugas 3. Monitoring kepatuhan berdasarkan moment identifikasi pasien

Tabel 3.5 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan pengetahuan petugas mengenai identifikasi pasien	Meningkatkan kepatuhan melakukan identifikasi sesuai moment identifikasi	Tercapaian peningkatan kepatuhan identifikasi pasien di setiap unit meningkat pada capaian bulan berikutnya	Melakukan training in house dengan pembagian kelas kecil (1 kelas minimal 5 petugas), selanjutnya cek lapangan untuk realisasi hasil pelatihan	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu bulan

2. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Tahun 2023 adalah 94.21%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Dari 10 unit kerja yang di observasi unit rawat inap 2A dan 3B masih belum mencapai target. Berikut rata-rata capaian unit :

- 1. IGD : 100%
- 2. Rawat Inap 2A : 94.59% : 4 pasien tidak dilakukan Upaya pencegahan resiko jatuh, asesmen ulang tidak dilakukan pada pasien dari 74 pasien yang di observasi.
- 3. Rawat Inap 2B : 100%
- 4. Rawat Inap 3A : 100%
- 5. Rawat Inap 3B : 64%: 19 pasien tidak dilakukan Upaya pencegahan resiko jatuh, asesmen ulang tidak dilakukan pada pasien dari 53 pasien yang di observasi.
- 6. Maternitas : 100%
- 7. Perinatologi : 100%
- 8. Rawat Jalan : 100%
- 9. Radiologi : 100%
- 10. ICU : 100%

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2023

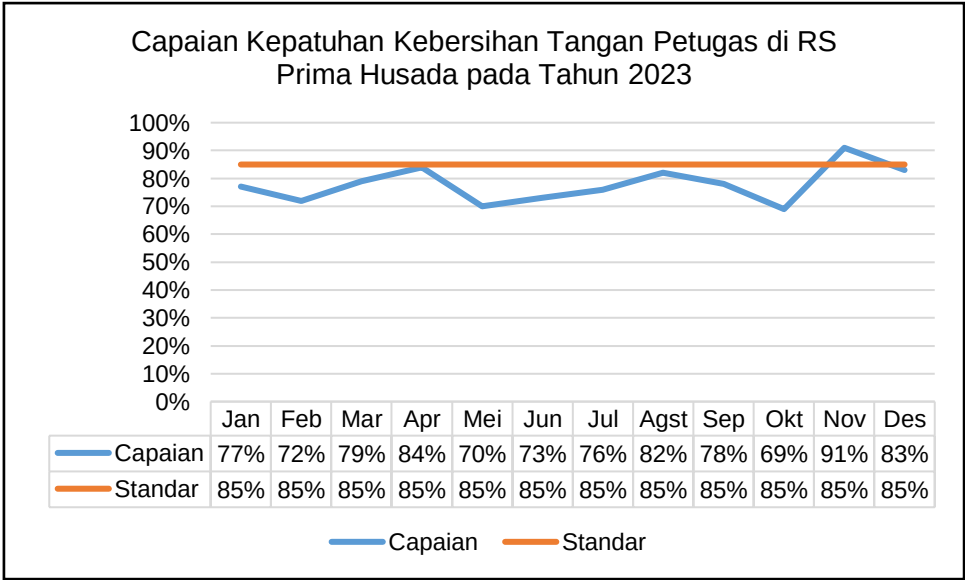
Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh Tahun adalah 94.21%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Rencana : a. memantau kepatuhan petugas dalam melakukan asesmen awal resiko jatuh & asesmen ulang terhadap pasien bila di indikasi terjadi perubahan kondisi b. memonitoring kepatuhan petugas dalam menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi resiko jatuh bagi pasien yang dianggap beresiko Harapan : semua petugas patuh melakukan asesmen awal / asesmen ulang pasien resiko jatuh di unitnya Tindakan : a. Pengecekan fasilitas penanda resiko jatuh di ruangan b. Ketepatan penggunaan resiko jatuh c. Pelatihan kepada security untuk skrinning resiko jatuh pada pintu masuk d. Supervisi kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan resiko jatuh
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam skrinning awal pasien jatuh di pintu masuk 2. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi asesmen awal pasien

	3. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi asesmen ulang pasien indikasi resiko jatuh 4. Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Berdasarkan hasil capaian resiko jatuh dari Bulan Desember rata-rata capaian nya yakni 94.21% 2. Berdasarkan hasil pengamatan di unit, masih ditemukan petugas yang tidak patuh dalam melakukan pemasangan tanda resiko jatuh pada box pasien, kadang petugas di ruangan juga lupa untuk menilai resiko jatuh pasien pada hari rawat ke berikutnya
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Tahun 2023 berdasarkan grafik tand mengalami peningkatan pada bulan januari – desember, namun masih belum mencapai standar, hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan petugas dalam memberikan tanda resiko jatuh yang belum dilaksanakan dengan baik, dan skrinning awal di pintu masuk RS Follow-up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervise oleh kepala ruang secara rutin

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan penulisan di RM	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam menghitung resiko jatuh pada pasien rawat inap	Tercapaiannya peningkatan kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh di beberapa unit rawat inap yang belum mencapai target Menjadi 100%	Mengingatnkan kepada petugas yang bertugas saat ditemukan RM yang tidak terkaji resiko jatuhnya	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu Bulan

3. Kepatuhan Kebersihan Tangan Petugas



Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada bulan Desember belum mencapai > 85%, mencapai 78.67%. pada grafik tersebut dapat diketahui kepatuhan hand hygiene berdasarkan 5 momen bulan Desember 2023 terendah adalah momen 1 yaitu sebelum ke pasien.

- 1. IRNA 3 A: 55%
- 2. IRNA 3B : 93%
- 3. IRNA 2A : 90%
- 4. IRNA 2B : 63%
- 5. ICU : 63%
- 6. MATERNITAS : 95%
- 7. NEONATOLOGI : 87%
- 8. IGD : 89%
- 9. IKO : 42%
- 10. IRJA : 74%
- 11. LAB : 100%

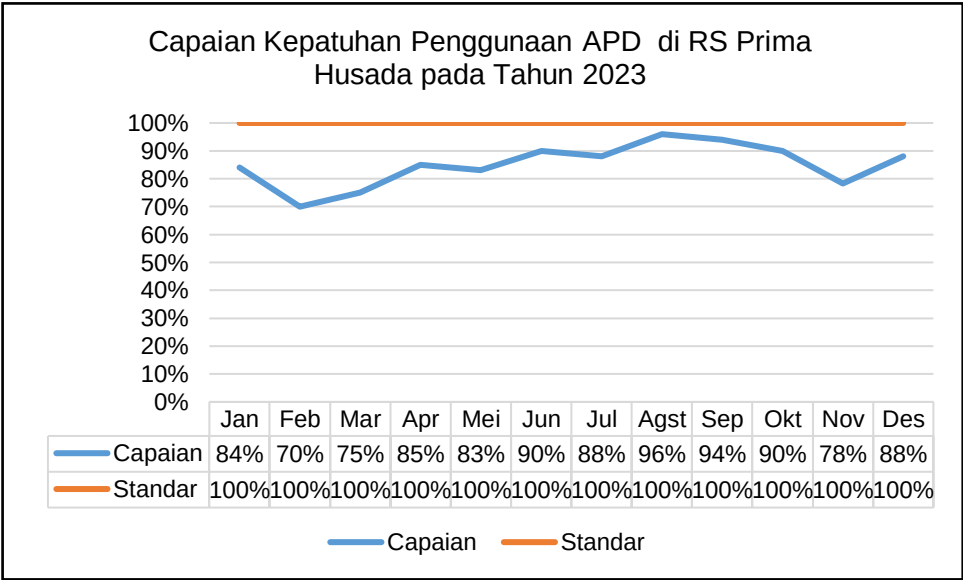
Tabel 3.10 PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Tahun 2023

Problem	Persentase kepatuhan hand hygiene pada bulan Desember < 85% yakni 78.67%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan hand hygiene secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf pelayanan medik melakukan hand hygiene dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit hand hygiene pada pstaf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang hand hygiene c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan hand hygiene staf di unit.
Do	Kepatuhan hand hygiene dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen sesuai 5 momen
Study	1. kepatuhan hand hygiene bulan Desember 2023 yaitu 83%. 2. kepatuhan terendah adalah IKO dan Irna 3A yaitu sebesar 42% dan 55%, dan kepatuhan tertinggi adalah unit Laboratorium 100%. 3. kepatuhan hand hygiene per profesi tertinggi adalah nakes lain sebesar 80%. 4. kepatuhan hand hygiene berdasarkan 5 momen bulan Desember 2023 terendah adalah momen 1 yaitu sebelum ke pasien sebesar 51% dan tertinggi momen setelah menyentuh cairan pasien sebesar 96%. 5. fasilitas kebersihan tangan bulan Desember 2023 sudah 100% terpenuhi 6. Ditemukannya petugas yang tidak melakukan hand hygiene sebelum menggunakan handscoon. Beberapa titik wastafel ditemukan tidak ada handwash dan handtowel.
Action	1. Review dan evaluasi pelaksanaan pelatihan PPI dasar 2. Kolaborasi dengan kabisd terkait monitoring kepatuhan kebersihan tangan 3. Reedukasi SPO hand hygiene berdasarkan 6 langkah sesuai 5 momen. 4. Jika ditemukan petugas yang tidak dapat mempraktikkan kebersihan tangan dengan benar, beri tugas untuk melakukan edukasi kelompok dan dikumpulkan berupa video. 5. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 7. Pemberian teguran saat melakukan supervisi hand hygiene.

Tabel 3.11 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Reedukasi SPO hand hygiene berdasarkan 6 langkah sesuai 5 momen.	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan cuci tangan sesuai SPO (6 langkah 5 moment)	Kepatuhan kebersihan petugas rawat inap sesuai dengan SPO hand hygiene	Sosialisasi SPO hand hygiene di setiap ruangan	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
2	Rencanakan pelatihan kebersihan tangan untuk staf baru yang sudah melewati masa training 3 bulan.	Meningkatkan skill petugas baru dalam melakukan kebersihan tangan	Skill petugas dalam melaksanakan cuci tangan sesuai dengan SPO	Pelatihan kebersihan tangan kepada staff baru	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
3	Reedukasi SPO hand hygiene berdasarkan 6 langkah sesuai 5 momen.	Menjalin koordinasi secara kesinambungan antar komite	Komite keperawatan dapat ikut serta dalam pemantauan kebersihan utamanya perawat	Rapat rutin dengan komite keperawatan	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
4	Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan kebersihan tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi berkala	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan

4. Kepatuhan Penggunaan APD



Hasil Capaian :

Pada grafik tersebut diketahui bahwa kepatuhan penggunaan APD pada bulan Desember 2023 adalah 91%. Dari 17 unit yang di observasi masih ditemukan 11 unit yang angka capaiannya belum 100%. Berikut merupakan capaian kepatuhan APD pada masing-masing unit :

1. Irna 3A	:	73%	9. Rawat Jalan	:	89%
2. Irna 3B	:	96%	10. Lab	:	94%
2. Irna 2A	:	84%	11. Farmasi	:	91%
3. Irna 2B	:	82%	12. Radiologi	:	96%
4. ICU	:	86%	13. Gizi & Dapur	:	86%

5. Maternitas	: 85%	14. CSSD	: 92%
6. Perinatologi	: 96%	15. Laundry	: 90%
7. IGD	: 86%	16. B3	: 98%
8. IKO	: 88%	17. CS	: 80%

Tabel 3.13 PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Tahun 2023

Problem	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penggunaan APD secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf pelayanan medik patuh dalam penggunaan APD dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan - Melakukan audit penggunaan APD pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. - Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan APD 1. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD staf di unit.
Do	Kepatuhan penggunaan APD meningkat hingga mencapai 100% di bulan berikutnya.
Study	1. Masih ditemukan petugas yang tidak tepat dalam penggunaan masker dan handscoon sesuai indikasi (IRNA). Petugas tidak menggunakan APD yang tepat di area dapur. 1. Ditemukan petugas yang tidak melakukan cuci tangan baik sebelum maupun setelah menggunakan handscoon.
Action	1. Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf. 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk monitoring penggunaan APD di unit. 4. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 1. Beri teguran saat melakukan monitoring penggunaan APD yang tidak sesuai indikasi di unit.

Tabel 3.14 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf.	Staf dapat melaksanakan penggunaan dan melepaskan APD sesuai langkah dengan indikasinya	Seluruh staf rawat inap dapat melaksanakan penggunaan APD dan pelepasan APD 100% benar	Resosialisasi	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
2	Beri feedback pada hasil temuan.	Ruangan dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki	All ruangan yang di audit	Pemberian feedback	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
3	Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk review kebatuhan penggunaan APD tangan di setiap pelatihan KDPK.	Menjalin koordinasi secara kesinambungan antar komite	Komite keperawatan dapat ikut serta dalam pemantauan kebersihan utamanya perawat	Rapat dengan komite keperawatan	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
4	Lakukan monitoring	Memastikan bahwa	All petugas melaksanakan	Monitoring dan evaluasi	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan

	evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	kepatuhan APD tangan sudah dilakukan	penggunaan APD tangan sesuai moment dan langkahnya			
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

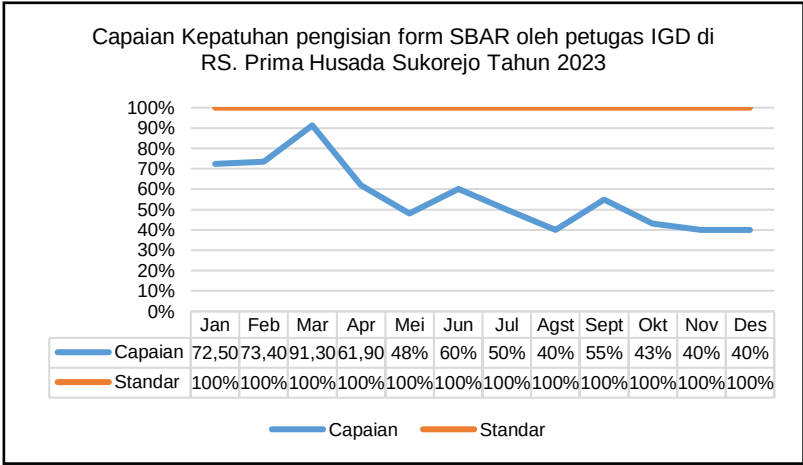
3.1.3 Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit

Tabel 3.15 Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit pada Tahun 2023

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Std	Bulan												Rata-rata	KET
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Indikator Sasaran Keselamatan Pasien	Identifikasi pasien : (sudah di laporkan setiap unit) Kepatuhan identifikasi pasien IGD	100%	100%	95.58%	100 %	100%	98,5 %	97,5 %	100%	100%	99.85 %	100%	100%	100%	99.29%	Dipertahankan
		Komunikasi Efektif : Kepatuhan pengisian form SBAR oleh petugas IGD	100%	72,5%	73,4%	91,3 %	61.90 %	48%	60%	50%	40 %	55 %	43%	40%	40%	56.26%	PDSA
		Pelabelan High Alert : Kejadian tidak adanya label high alert pada obat di IGD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipertahankan
		Penanda operasi : Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
		Hand Hygiene : Kepatuhan hand hygiene petugas IGD	100%	100%	100%	86%	75%	73%	87%	85%	86%	89%	83%	77%	89%	85.830%	PDSA
		Resiko Jatuh : Kepatuhan upaya pencegahan pasien IGD jatuh	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	95,74 %	100%	100%	100%	100%	100%	91.96%	PDSA
2	Pelayanan Klinis Prioritas	Angka kelengkapan asesmen awal medis pasien IGD	≥80%	49.52%	83.19%	74.9 1%	70.16 %	79.99 %	94.37 %	97.77 %	96.79 %	92.81 %	93.47 %	89,53%	89.14%	76.84%	Dipertahankan
		Waktu tanggap pelayanan gawat darurat pada pasien ≤ 5 menit setelah pasien datang	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87.97%	99%	Dipertahankan
3	Renstra RS	Waktu tunggu di IGD sebelum masuk rawat Inap ≥ 3jam (paien P2 & P3)	≤20%	42.38%	12.16%	9.05 %	4.87 %	19%	28.86 %	24,33 %	19.71 %	16.35 %	46.41 %	14,59%	15.52%	17.86%	Dipertahankan
		Kematian Pasien Di Instalasi Gawat Darurat ≤24 Jam	≤ 2/ 1000 pasien	7/663 pasien	8/600 pasien	2/64 1	9/697	12/72 6	9/686	9/715	10/87 5	4/899	8/853	8/884	8/966	8/836	PDSA
4	Perbaikan Sistem	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Manajemen Resiko	Angka tidak terpasangnya gelang identitas pasien IGD	0%	0.12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5.44%	0%	0%	0,46%	Dipertahankan

3.1.4 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit yang Tidak Di inginkan

1. Kepatuhan pengisian form SBAR oleh Petugas IGD



Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil di atas kepatuhan petugas melakukan pengisian SBAR pada Tahun 2023 mencapai 40%, capaian tersebut belum mencapai target 100%. Banyak sbar yang tidak terisi pada bagian :

- 1. Appearance: perubahan pola makan, status kesadaran, pencernaan, pernapasan, perubahan kondisi kulit.
- 2. Keterangan SBAR
- 3. Tanda tangan pemberi pesan

Tabel 3.17 PDSA Capaian Kepatuhan pengisian form SBAR oleh petugas IGD Tahun 2023

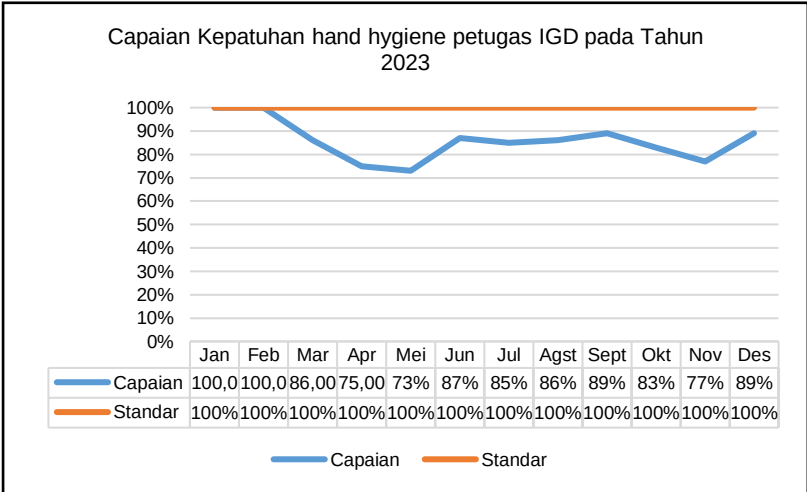
Problem	Rata-rata capaian kepatuhan pengisian form SBAR oleh petugas IGD padabulan desember tahun 2023 adalah 40% belum mencapai target 100%
Step	Rencana : Meningkatkan kepatuhan pengisian SBAR petugas IGD dengan melaksanakan monitoring dan supervisi oleh kepala ruangan dengan koordinasi dengan tim PKRS Harapan : Kepatuhan petugas dalam pengisian SBAR di IGD tercapai 100% Tindakan : 1. Monitoring dan supervise secara rutin oleh kepala ruangan 2. Melaksanakan pengisian SBAR sesuai dengan SPO 3. Peneguran secara langsung kepada petugas yang tidak melengkapi form SBAR dan dilakukan pengisian pada hari yang sama 4. Pengecekan kelengkapan form SBAR sebelum pasien dipulangkan / dinaikan ke rawat inap 5. Koordinasi dengan PKRS untuk melakukan monitoring dan supervi kepatuhan petugas
Plan	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Kepatuhan pengisian form SBAR oleh petugas IGD 2. Form SBAR pasien IGD
Do	Rencana : Meningkatkan kepatuhan pengisian SBAR petugas IGD dengan melaksanakan monitoring dan supervisi oleh kepala ruangan dengan koordinasi dengan tim PKRS Harapan : Kepatuhan petugas dalam pengisian SBAR di IGD tercapai 100% Tindakan : 1. Pelatihan penulisan SBAR pada dokter IGD 2. Pengecekan kelengkapan form SBAR sebelum pasien dipulangkan / dinaikan ke rawat inap 3. Koordinasi dengan PKRS untuk melakukan monitoring dan supervi kepatuhan petugas
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Kepatuhan petugas dalam pengisian SBAR sesuai dengan SPO 2. Persentase capaian kepatuhan pengisian SBAR oleh petugas IGD pada bulan desember tahun 2023 sebesar 40%, belum mencapai target. ketidakpatuhan dalam melakukan pengisian SBAR disebabkan oleh :

	a. Masih ditemukannya SBAR yang dituliskan oleh perawat b. Dokter tidak menuliskan SBAR sendiri sesuai dengan tugasnya
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Belum tersosialisasinya dengan baik penulisan SBAR kepada dokter di IGD sehingga masih ditemukan SBAR yang tidak lengkap di ruangan Follow-Up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan selanjutnya, monitoring dan supervise oleh kepala ruangan dan melakukan koordinasi dengan Tim PKRS

Tabel 3.18 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pelatihan penulisan SBAR	Meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan dalam penulisan SBAR di IGD	Capaian Ketidakpatuhan pengisian form SBAR oleh petugas IGD bulan Desember 40% naik 100% pada tahun berikutnya	Pelatihan online kepada dr. IGD yang dilakukan oleh ka. Bidang pelayanan & ka. Ruang rekam medis	Ka. Bidang Yangmed Ka. Ruang RM Ka. Ruang IGD	Sebulan

2. Angka Kepatuhan Hand Hygiene Petugas IGD



Hasil Capaian :

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian angka kepatuhan hand hygiene petugas IGD pada Desember adalah 89%, angka tersebut belum mencapai target 100%..

Tabel 3.20 PDSA Capaian Angka kepatuhan hand hygiene petugas IGD pada Tahun 2023.

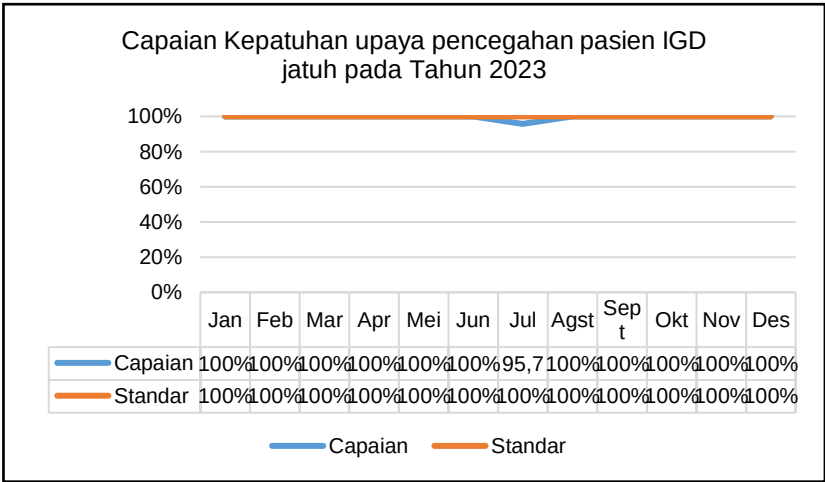
Problem	Rata-rata capaian angka kepatuhan hand hygiene pada Bulan Desember Tahun 2023 adalah 89% belum mencapai target 100%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke staf di unit IGD mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan hand hygiene secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf igd melakukan hand hygiene dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit hand hygiene pada staf IGD secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang hand hygiene c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan hand hygiene staf di unit.
Do	Kepatuhan hand hygiene dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen sesuai 5 momen
Study	1. kepatuhan hand hygiene bulan Desember 2023 mengalami peningkatan 1% yaitu

	89%. 2. Ditemukannya petugas yang tidak melakukan hand hygiene sebelum menggunakan handscoon. Beberapa titik wastafel ditemukan tidak ada handwash dan handtowel.
Action	1. Reeducasi SPO hand hygiene berdasarkan 6 langkah sesuai 5 momen. 2. Rencanakan pelatihan kebersihan tangan untuk staf baru yang sudah melewati masa training 3 bulan. 3. Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk review kebersihan tangan di setiap pelatihan KDPK. 4. Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing. 5. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 7. Pemberian teguran saat melakukan supervisi hand hygiene.

Tabel 3.21 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Reeducasi SPO hand hygiene berdasarkan 6 langkah sesuai 5 momen.	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan cuci tangan sesuai SPO (6 langkah 5 moment)	Kepatuhan kebersihan petugas IGD sesuai dengan SPO hand hygiene	Sosialisasi SPO hand hygiene di setiap ruangan	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
2	Rencanakan pelatihan kebersihan tangan untuk staf baru yang sudah melewati masa training 3 bulan.	Meningkatkan skill petugas baru dalam melakukan kebersihan tangan	Skill petugas dalam melaksanakan cuci tangan sesuai dengan SPO	Pelatihan kebersihan tangan kepada staff baru	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
3	Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk review kebersihan tangan di setiap pelatihan KDPK.	Menjalin koordinasi secara kesinambungan antar komite	Komite keperawatan dapat ikut serta dalam pemantauan kebersihan utamanya perawat IGD	Rapat rutin dengan komite keperawatan	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
4	Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan	All petugas IGD melaksanakan kebersihan tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi berkala	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan

3. Kepatuhan upaya pencegahan pasien IGD jatuh



Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian diatas dapat disimpulkan bahwa, rata-rata capaian Kepatuhan upaya pencegahan pasien IGD jatuh pada Bulan Desember tahun 2023 mencapai 100% namun rata-rata pada tahun 2023 belum mencapai target 100%.

Tabel 3.23 PDSA Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Pasien IGD Jatuh pada Tahun 2023

Problem	Rata-rata capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Pasien IGD Jatuh pada Bulan Desember Tahun 2023 adalah 91% belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk Kepatuhan Upaya Pencegahan Pasien IGD Jatuh
Plan	Rencana : Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melakukan Kepatuhan Upaya Pencegahan Pasien IGD Jatuh Harapan : 1. Upaya pencegahan resiko jatuh di IGD dapat dilaksanakan sesuai SOP 2. Terjadi peningkatan kepatuhan pencegahan pasien jatuh di IGD agar sesuai target 100% Tindakan : 1. Monitoring fasilitas tanda resiko jatuh di IGD 2. Supervisi oleh kepala ruang
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Kepatuhan petugas dalam pemberian tanda resiko jatuh pada pasien
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Capaian rata-rata kepatuhan upaya pencegahan pasien IGD jatuh pada bulan tahun 2023 mencapai 91% belum sesuai target capaian.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pasien IGD sudah dilakukan oleh petugas hal ini perlu adanya pemantauan secara rutin untuk mempertahankan capaian Upaya pencegahan pasien IGD jatuh Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Supervisi rutin oleh tim SKP

Tabel 3.24 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pengecekan tanda resiko jatuh di IGD	Meningkatkan penerapan tanda resiko jatuh pasien IGD	Seluruh pasien resiko jatuh dapat dilakukan penandaan resiko jatuh pada bednya dan rekam medisnya	Monitoring dan supervisi penggunaan tanda resiko jatuh	Ka. Ruangan Tim SKP Komite Mutu	Satu Bulan

4. Kematian Pasien Di Instalasi Gawat Darurat ≤24 Jam

Tabel 3.28 Analisis Capaian Indikator Prioritas RS yang Tidak Di Inginkan pada Tahun 2023

Stand ar	Judul Indikator	Stan dar	Capaian Bulan												Rat a-rata	Area
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	De s		
Priorit as-RS	Kematian Pasien Di Instalasi Gawat Darurat ≤24 Jam	≤ 2/ 1000 pasie n	7/66 3 pasi en	8/60 0 pasi en	2/64 1	9/69 7	12/7 26	9/68 6	9/71 5	10/8 75	4/89 9	8/85 3	8/88 4	8/9 66	8/83 6	IGD

Hasil Capaian :

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa rata-rata capaian kematian pasien di IGD ≤24 Jam rata-rata adalah 8 pasien dari 966 pasien. Capaian tersebut belum sesuai dengan target ≤ 2 pasien dari 1000 pasien yang datang di IGD.

Tabel 3.29 PDSA Capaian Kematian Pasien Di Instalasi Gawat Darurat ≤24 Jam pada Tahun 2023

Problem	Rata-rata capaian kematian pasien di IGD ≤ 24 jam pada Bulan Desember 2023 adalah 8 pasien dari 966 pasien yang berkunjung di IGD
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kematian pasien di IGD ≤ 24 jam
Plan	Rencana : Mengurangi kematian pasien di IGD ≤ 24 jam dengan melaksanakan peningkatan skill maupun kinerja petugas IGD dan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja oleh kepala ruang Harapan : Kematian pasien di IGD ≤ 24 jam tercapai $\leq 2/1000$ pasien Tindakan : 1. Evaluasi kinerja petugas IGD oleh Kepala Ruang 2. Pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai dengan SPO 3. Bekerja sama dengan spesialis emergency untuk penanganan lebih lanjut 4. Mengadakan seminar emergency bersama tim dSepter igd dan spesialis emergency untuk penanganan pasien emergency
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Kematian pasien IGD ≤ 24 Jam 2. Kinerja petugas dalam menangani pasien di IGD
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Capaian rata-rata kematian pasien di IGD ≤ 24 jam Bulan Desember tahun 2023 adalah 8/966 angka tersebut belum mencapai target ≤ 2 pasien / 1000, hal ini disebabkan oleh : a. Pasien yang datang ke igd sudah dalam kondisi buruk
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Hasil capaian indikator untuk Bulan Desemberr Tahun 2023 diperoleh capaian belum sesuai target yang ditentukan, terjadi penurunan angka kematian pasien dari bulan april sampai Desember Follow-Up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya.

Tabel 3.30 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan softskills dan hardskills petugas igd	Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien yang dalam kondisi buruk	Tercapainya pengurangan angka Kematian Pasien Di Instalasi Gawat Darurat ≤ 24 dari 8/966 menjadi 2/1000 pasien pada tahun berikutnya	Peningkatan pengetahuan melalui seminar maupun pembahasan studi kasus bersama	Ka.ruang IGD Kabid medis	Satu bulan

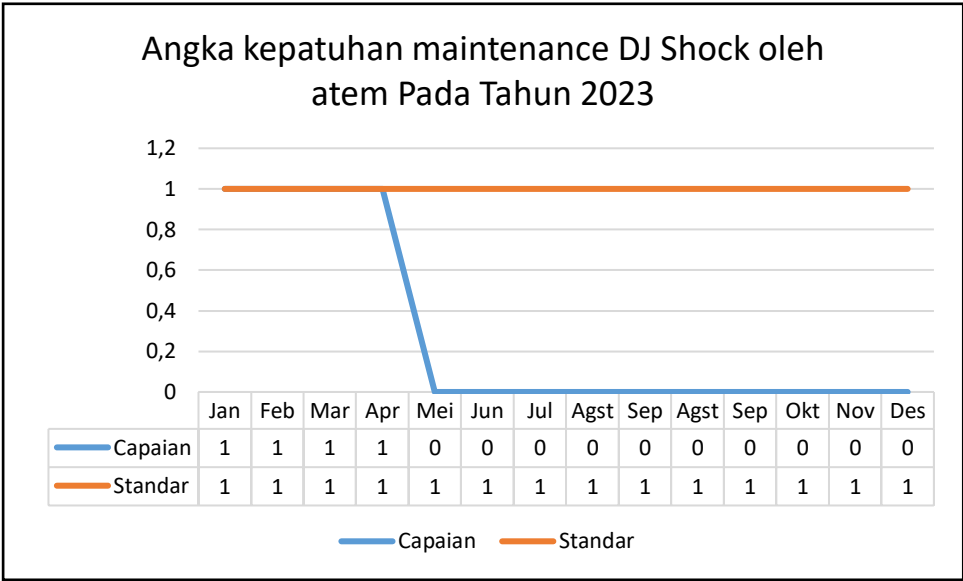
3.1.5 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit

1. Instalasi Gawat Darurat

Tabel 3.31 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Gawat Darurat pada Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan												Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka kepatuhan maintenance DJ Shock oleh atem	≤ 1 kali/bulan	1 kali	1 kali	1 Kali	1 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	PDSA
2	Angka Respon Time WA Perujuk ≥ 5 Menit	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4.16%	Dipertahankan
3	Kejadian Tidak Tertutupnya Tirai Pasien IGD	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipertahankan
4	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/PPGD/GELS/ALS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Ketersediaan Tim penanggulangan bencana Kesiapsiagaan =	1 tim	1 tim	1tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	Dipertahankan

	Instrumennya : pelatihan / simulasi/ review															
6	Angka pulang atas permintaan sendiri	0%	1.65%	0.67%	0.15%	0.55%	0.41%	1.02%	0,56%	1,6%	1.66%	1.05%	0.90%	0.93%	0.88%	PDSA



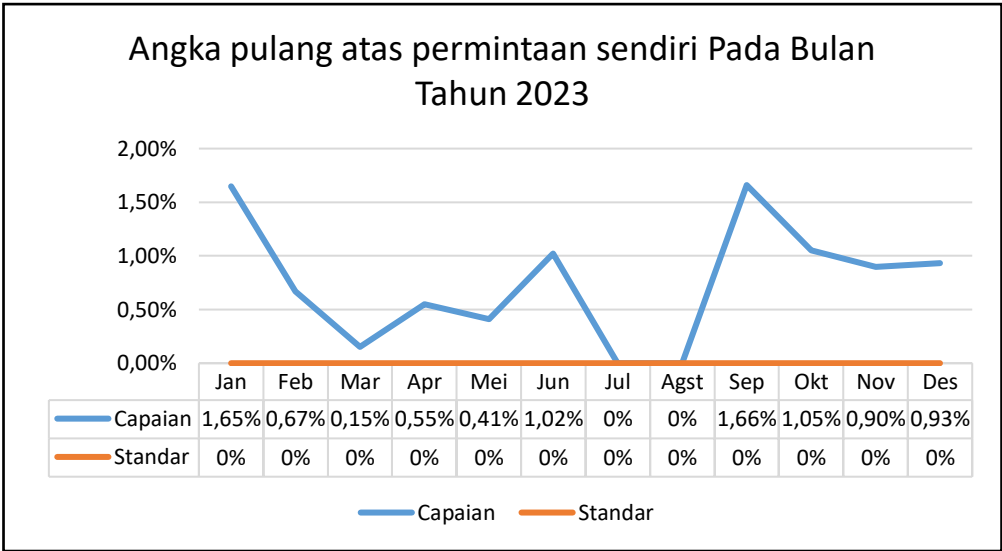
Berdasarkan capaian pada bulan Desember ata-tata angka ketidakpatuhan *maintenance* DJ Shock oleh atem mencapai 0 kali. Yang artinya dalam bulan Desember atem tidak mengecek sama sekali DJ shock yang ada di IGD.

Tabel 3.33 PDSA Capaian Angka kepatuhan *maintenance* DJ Shock oleh atem pada Tahun 2023

Problem	Capaian angka kepatuhan <i>maintenance</i> DJ Shock oleh atem Bulan Deseember Tahun 2023 sebesar 0 kali
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk Angka ketidakpatuhan <i>maintenance</i> DJ Shock oleh atem
Plan	1. Rencana : Meningkatkan kepatuhan atem dalam <i>maintence</i> DJ shock di IGD 2. Harapan : DJ Shock dapat yermaintenance rutin 1 bulan sekali 3. Tindakan : 1. Peningkatan fungsi PJ alat di ruangan untuk menglist ala tapa saja yang perlu dilakukan maintenance dalam 1 bulan 2. Pengawasan oleh kepala ruangan agar tugas PJ alat berjalan maksimal 3. Koordinasi dengan petugas IPSRS
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ?a 1. Kartu maintenance alat yang ada di IGD apakah sudah terupdate atau belum
Study	Apa yang anda pelajari ? apakah sesuai target capaian ? Capaian Angka ketidakpatuhan <i>maintenance</i> DJ Shock oleh atem pada bulan Desember mencapai 0 kali / tidak dilakukan maintenance pada DJ Shock di IGD. Hal ini disebabkan oleh : a. PJ alat tidak memiliki inventaris alat dengan baik sehingga data mengenai maintenance alat tidak terkondisikan dengan baik b. Kurangnya supervisi oleh kepala ruangan untuk fungsi setiap PJ di unitnya c. Kurangnya koordinasi dengan IPSRS d. Keterbatasan tenaga petugas IPSRS dalam mengkondisikan maintenance alat
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Masih belum berjalan secara maksimal PJ alat di unit untuk melakukan inventasrisasi alat, hal ini dibuktikan dengan hasil inventaris alat baik/rusak yang tidak terupdate / tidak sesuai dengan kondisi lapangan Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan kepala ruang dan PJ alat untuk rutin mendata alat-alat yang belum termaintenance dengan baik 2. Koordinasi dengan IPSRS untuk membuat jadwal maintenance alat di IGD secara rutin 3. Koordinasi dengan kepala bidang penunjang agar selalu mensupervsisi kepatuhan petugas IPSRS dalam melakukan pemeliharaan alat

Tabel 3.34 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan fungsi dan tugas PJ alat di IGD	Meningkatkan monitoring dalam pengawasan alat di ruangan	Tercapainya peningkatan kepatuhan atem dalam memaintenance DJ shock di unir	Menjelaskan mengenai tupoksi setiap PJ di unit	Ka.ruangan PJ alat	Satu bulan
2	Supervisi oleh Karu IGD	Meningkatkan kepatuhan PJ alat dalam melaksanakan inventarisasi & maintenance alat dengan baik	Tercapainya proses inventarisasi alat sesuai kondisi alat dilapangan	Supervisi data inventaris unit secara berkala	Ka. Ruangan Ka. Bidang Penunjang	Satu bulan



Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian angka pulang atas pulang atas permintaan sendiri pada bulan Desember mencapai 0.93% belum mencapai target 0%. Dari 966 pasien IGD yang diamati terdapat 9 pasien yang menyatakan pulang atas permintaan sendiri. permintaan sendiri di IGD yang mayoritas dilakukan oleh pasien umum.

1. Pada pasien dengan kasus operatif yang berdomisili luar kota cenderung menginginkn operasi di tempat asalnya
2. Pasien dengan kategori orang tidak mampu yang terkait biaya
3. Keluarga dan pasien menolak dirujuk karnan menurutnya kondisi sudah membaik

Tabel 3.36 PDSA Capaian Angka Pulang Atas Permintaan Sendiri pada Tahun 2023

Problem	Rata-rata angka pulang atas permintaan sendiri pada Bulan Desember Tahun 2023 sebesar 0.93%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk Angka Pulang Atas Permintaan Sendiri
Plan	Rencana : Menurunkan angka pulang atas permintaan sendiri, dengan melakukan koordinasi antar PPA dan MOD untuk melakukan edukasi mengenai kondisi pasien Harapan : Angka pulang atas permintaan sendiri di IGD tercapai 0% Tindakan : kolaborasi edukasi antar PPA dan MOD untuk mengKIE pasien yang meminta pulang
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. angka pulang atas permintaan sendiri pasien di IGD

	2. upaya yang diambil oleh petugas unit ketika terdapat pasien yang ingin pulang atas permintaan sendiri
Study	Apa yang anda pelajari ? apakah sesuai target capaian ? - persentase rata-rata capaian angka pulang atas permintaan sendiri di IGD mencapai 0.93%, angka tersebut belum mencapai target yang ditentukan 0%. Hal ini disebabkan oleh : - Pasien dengan domisili luar kota - Pasien dengan tidak adanya jaminan kesehatan - Asumsi keluarga terhadap kondisi pasien
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? - petugas di unit sudah menerapkan KIE mengenai biaya tindakan kepada pasien dan keluarga sebelum dilakukan tindakan tersebut, namun pasien masih berkeinginan untuk pulang karena terkendala dari faktor biaya Follow-up dan Rencana Lanjutan - koordinasikan antar PPA dan MOD jika terdapat pasien yang pulang atas permintaan sendiri - supervisi dan monitoring oleh kepala ruangan mengenai kepatuhan petugas dalam melakukan KIE kepada pasien yang pulang atas permintaan sendiri

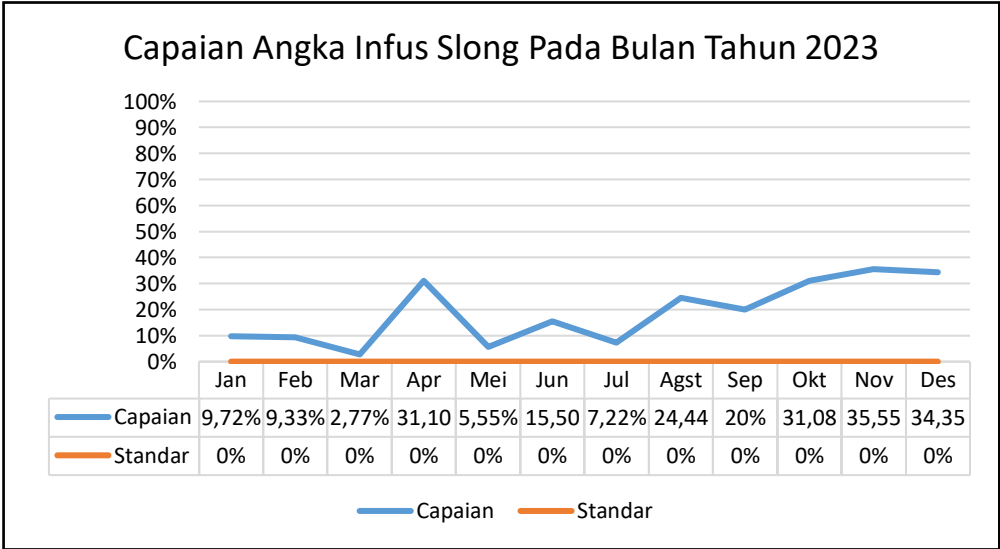
Tabel 3.37 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	koordinasikan antar PPA dan MOD jika terdapat pasien yang pulang atas permintaan sendiri	Menurunkan angka pulang atas permintaan sendiri	Tercapainya pengurangan pulang atas permintaan sendiri dari 0,93% menjadi 0% pada bulan berikutnya	Kolaborasi KIE pasien antara petugas dan MOD	Ka. Ruangan MOD	Satu bulan

2. Instalasi Rawat Inap 2A

Tabel 3.35 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rawat Inap 2A pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan												Rat a-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka Infus Slong	0%	9.72%	9.33%	2.77%	31.1%	5.55%	15.5%	7,22%	24.44%	20%	31.08%	35.55%	34.35 %	18.3 %	PDSA
2	Angka pasien pulang atas permintaan sendiri	0%	4.16%	4%	0.98%	0.98%	0%	1.6%	0,740%	33.3%	2%	0%	0%	0%	3.9 %	PDSA
3	Angka Phlebitis	≤ 1.5%	38.57%	41.09%	3.70%	3.70%	16.6%	12.22%	0%	0%	7%	27.63%	26.58%	24.19 %	16.8 %	PDSA
4	Ketidaklengkapan Dokumen Rekam Medis Pada Pasien KRS ≥24 Jam	≤ 1%	0%	0%	0%	0%	1.25%	0%	6,66%	0%	0%	7.92%	4.50%	3.5 %	1.4 %	Dipertahankan



Hasil Capaian :

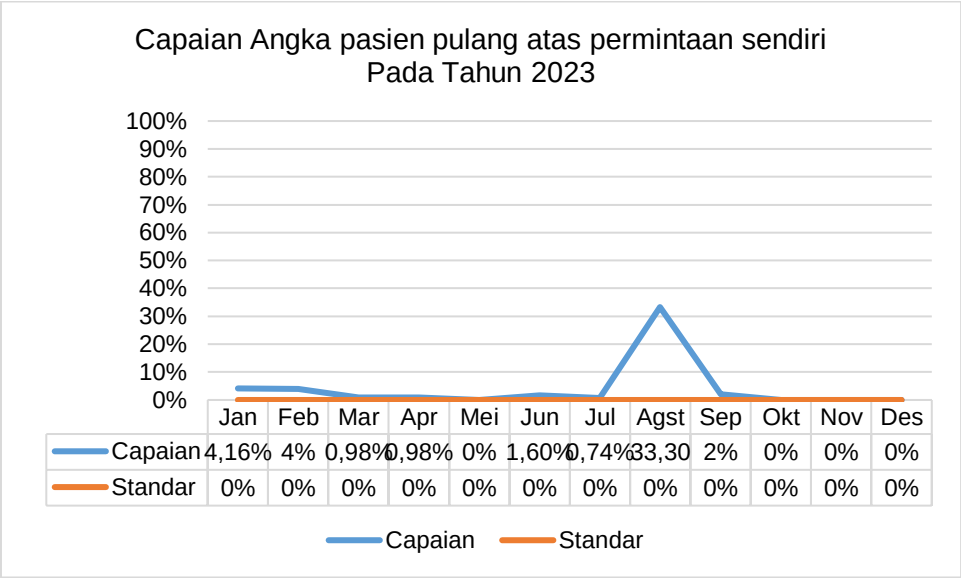
Berdasarkan capaian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian infus slong pada bulan Desember mengalami peningkatan pada bulan sebelumnya mencapai 34.35%. dari 131 pasien yang di observasi terdapat 45 pasien yang mengalami infus slong, hal ini meningkat dari pada pasien pada bulan November mencapai 34.35%.

Tabel 3.40 PDSA Capaian Angka Infus Slong pada Tahun 2023

Problem	Rata-rata angka infus slong pada Bulan Desember Tahun 2023 sebesar 18.3%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk Angka infus slong
Plan	1. Rencana : Menurunkan capaian angka infus slong di unit Rawat Inap 2A, dengan cara monitoring secara rutin infus yang tersisa untuk segera dilakukan pengantian. 2. Harapan : Angka infus slong di unit rawat inap 2A tercapai 0% 3. Tindakan : 1. Monitoring kepatuhan staff yang berdinass dalam melakukan pergantian infus yang sudah mendekati habis 2. Koordinasi antara Kepala ruang dan PJ Shift dan seluruh petugas untuk memonitoring cairan infus pasien

Tabel 3.37 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan supervisi dalam pengawasan cairan infus pasien	Mengurangi angka infus slong di ruangan	Tercapainya penurunan angka infus slong dari 18.3% menjadi 0% pada bulan berikutnya	Supervisi kepatuhan petugas dalam pengecekan cairan infus secara berkala	Ka. Ruangan	Satu Bulan



Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian diatas, angka pasien pulang atas permintaan sendiri pada bulan Desember mencapai 0%, dari 148 pasien di rawat inap 2A tidak ditemui pasien pulang paksa

Tabel 3.39 PDSA Capaian Angka pasien pulang atas permintaan sendiri pada Tahun 2023

Problem	Rata-rata angka pulang atas permintaan sendiri pada Bulan Desember Tahun 2023 sebesar 0%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk Angka pasien pulang atas permintaan sendiri
Plan	1. Rencana : Menurunkan angka pulang atas permintaan sendiri, dengan melakukan koordinasi antar PPA dan MOD untuk melakukan edukasi mengenai kondisi pasien 2. Harapan : Angka pulang atas permintaan sendiri di unit Irna 2A tercapai 0% 3. Tindakan : 1. kolaborasi edukasi antar PPA dan MOD untuk mengKIE pasien yang meminta pulang 2. supervisi dan monitoring oleh kepala ruangan
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. angka pulang atas permintaan sendiri pasien rawat inap 2A 2. upaya yang diambil oleh petugas unit ketika terdapat pasien yang ingin pulang atas permintaan sendiri
Study	Apa yang anda pelajari ? apakah sesuai target capaian ? 1. persentase rata-rata capaian angka pulang atas permintaan sendiri di Unit Rawat Inap 2A mencapai 4.07%, angka tersebut belum mencapai target yang ditentukan 0%. Hal ini disebabkan oleh : alasan ekonomi dan alasan pribadi pasien
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. petugas di unit sudah menerapkan KIE mengenai biaya tindakan kepada pasien dan keluarga sebelum dilakukan tindakan tersebut, namun pasien masih berkeinginan untuk pulang karena terkendala dari faktor biaya & faktor pribadi Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. koordinasikan antar PPA dan MOD jika terdapat pasien yang pulang atas permintaan sendiri 2. supervisi dan monitoring oleh kepala ruangan mengenai kepatuhan petugas dalam melakukan KIE kepada pasien yang pulang atas permintaan sendiri

Tabel 3.40 Rencana Tindak Lanjut

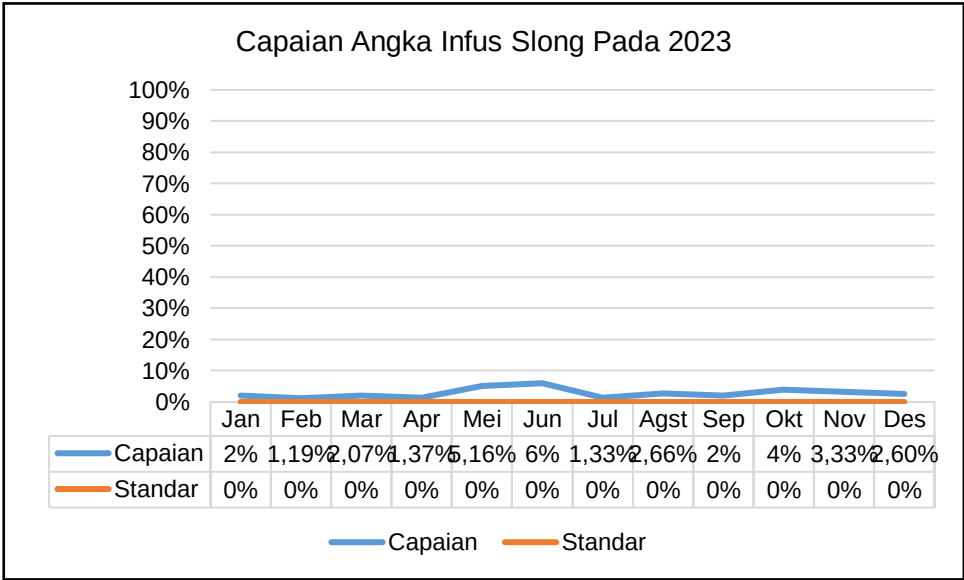
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	koordinasikan antar PPA dan MOD jika terdapat pasien yang pulang atas	Menurunkan angka pulang atas permintaan sendiri	Mempertahankan capaian permintaan sendiri sebesar	Kolaborasi KIE pasien antara petugas dan MOD	Ka. Ruangan MOD	Satu bulan

	permintaan sendiri		0% pada Tahun Berikutnya			
--	--------------------	--	--------------------------	--	--	--

3. Instalasi Rawat Inap 2B

Tabel 3.41 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rawat Inap 2B pada Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan												Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka Infus Slong	0%	2%	1.19%	2.07%	1.37%	5.16%	6%	1.33%	2.66%	2%	4%	3.33%	2.6%	2,8%	PDSA
2	Angka pasien pulang atas permintaan sendiri	0%	2.5%	0%	0.69%	1.37%	0.64%	2%	1.33%	2%	2%	4%	4.82%	5.3%	2.2%	PDSA
3	Angka Phlebitis	≤ 1.5%	4.4%	9.63%	0.34%	0%	2.58%	2.6%	2,66%	0.66%	3.33%	4.6%	0.66%	2%	2.6%	PDSA
4	Ketidaklengkapan Dokumen Rekam Medis Pada Pasien KRS ≥24 Jam	≤ 1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2.6%	0.2%	Dipertahankan



Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian pada bulan Desember angka infus slong mencapai 2.6%, angka tersebut tidak mencapai target 0%. Dari 150 pasien yang diobservasi ditemukan 4 pasien mengalami infus slong. Capaian ini menurun dibanding pada bulan sebelumnya yang mencapai 3.33% yakni dari 150 pasien yang di observasi di temukan 6 pasien mengalami infus slong

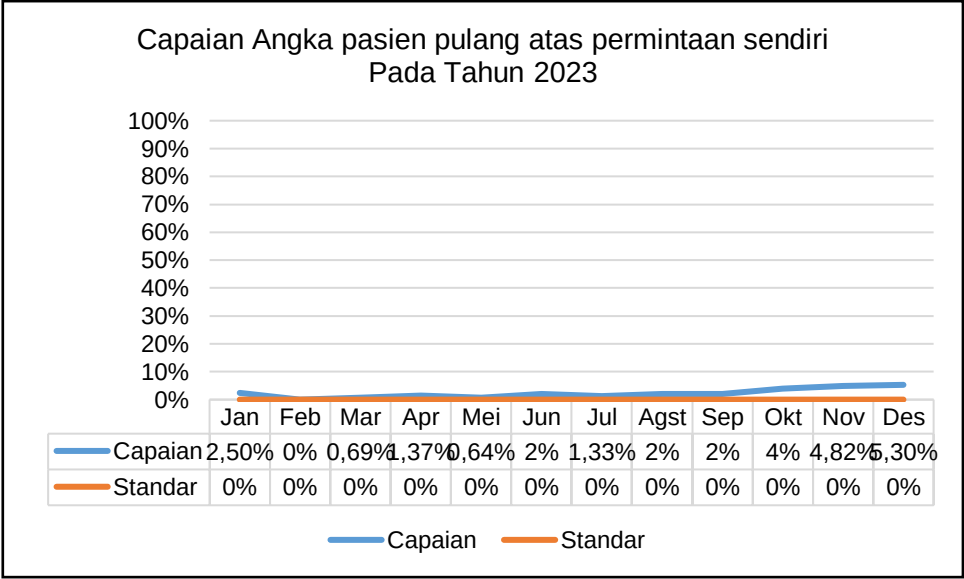
Tabel 3.43 PDSA Capaian Angka Phlebitis pada Tahun 2023

Problem	Rata-rata angka infus slong pada Bulan Desember Tahun 2023 sebesar 2.8%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk Angka infus slong
Plan	1. Rencana : Menurunkan capaian angka infusslong di unit Rawat Inap 2B, dengan cara monitoring secara rutin infus yang tersisa untuk segera dilakukan pengantian. 2. Harapan : Angka infus slong di unit rawat inap 2A tercapai 0% 3. Tindakan : 1. Monitoring kepatuhan staff yang berdinass dalam melakukan pergantian infus yang sudah mendekati habis 2. Koordinasi antara Kepala ruang dan PJ Shift dan seluruh petugas untuk memonitoring cairan infus pasien
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Angka infus slong di unit Rawat Inap 2A 2. Kepatuhan petugas dalam melakukan monitoring cairan infus pasien
Study	Apa yang anda pelajari ? apakah sesuai target capaian ? 1. kepatuhan petugas di unit dalam melakukan pengawasan cairan infus pasien 2. persentase angka infus slong di unit rawat inap 2A pada Bulan Desember Tahun 2023 adalah 2.60%, angka tersebut belum mencapai target 0%. Hal ini disebabkan oleh :

	a. kurangnya monitoring petugas di unit dalam melakukan pengawasan cairan infus pasien b. tidak segera dilakukan pengantian infus yang baru saat pasien memberitahukan bahwa cairan infus akan habis
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. perhatian petugas di unit rawat inap 2B dikategorikan kurang 2. hasil capaian indikator mutu untuk Bulan Desember Tahun 2023 diperoleh grafik tren menurun karena pada Bulan Desember rata-rata capaian 2.60% Follow-up dan Rencana Lanjutan evaluasi dan monitoring pada bulan berikutnya oleh kepala ruangan mengenai kepatuhan petugas di unit dalam melakukan monitoring cairan infus pasien

Tabel 3.43 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan supervisi dalam pengawasan cairan infus pasien	Mengurangi angka infus slong di ruangan	Tercapainya penurunan angka infus slong dari 2.6% menjadi 0% pada tahun berikut	Supervisi kepatuhan petugas dalam pengecekan cairan infus secara berkala	Ka. Ruangan	Satu Bulan



Hasil Capaian :

Berdasarkan tabel diatas capaian angka pulang atas permintaan sendiri pada pasien Rawat Inap 2B mencapai 5.30%. dari 150 pasien yang di observasi didapatkan 8 pasien pulang atas permintaan sendiri dengan data sebagai berikut :

1. penjamin BPJS 100%
2. Alasan APS : Alasan Pribadi & Menolak rujuk

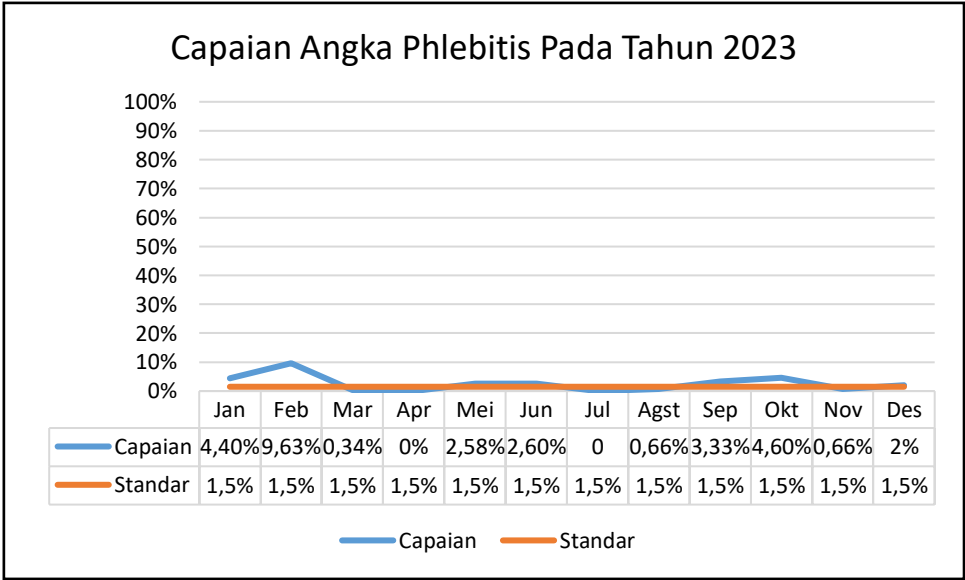
Tabel 3.46 PDSA Capaian Angka Pulang atas permintaan sendiri pada Desember Tahun 2023

Problem	Capaian angka pulang atas permintaan sendiri pada bulan Desember belum mencapai target 0% yakni 5.30%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk Angka pulang atas permintaan sendiri
Plan	Rencana : Menurunkan capaian angka pulang atas permintaan sendiri melalui koordinasi dengan MOD maupun KIE pasien yang bersangkutan Harapan : capaian angka pulang atas permintaan sendiri mencapai 0% Tindakan : 1. mengKIE pasien mengenai konsekuensi jika pulang paksa dilakukan 2. koordinasi dengan MOD untuk mengedukasi pasien
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ?

	Pasien pulang atas permintaan sendiri di rawat inap
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Capaian angka pulang paksa di rawat 2B pada bulan Desember mencapai 5.30% angka tersebut belum mencapai target yang ditentukan 0%, hal ini disebabkan oleh : alasan pribadi pasien dan pasien menolak rujuk
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Terjadi peningkatan angka pulang atas permintaan sendiri dari bulan juni sampai Desember 2023. Seluruh petugas IRNA mampu mengkaji dan mengevaluasi alasan pasien dan keluarga yang meminta pulang paksa sebelum ada advice dari dSepter penanggung jawab untuk diijinkan pulang Follow-Up dan Rencana Lanjutan - Melakukan pengkajian ulang kepada pasien dan keluarga yang meminta pulang paksa sebelum mendapatkan advice pulang dengan izin dari dSepter penanggungjawab - Koordinasi dengan MOD - Evaluasi secara berkala

Tabel 3.47 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	koordinasikan antar PPA dan MOD jika terdapat pasien yang pulang atas permintaan sendiri	Menurunkan angka pulang atas permintaan sendiri	Tercapainya pengurangan pulang atas permintaan sendiri dari 5.30% menjadi 0% pada bulan berikutnya	Kolaborasi KIE pasien antara petugas dan MOD	Ka. Ruang MOD	Satu bulan



Hasil Capaian :

Berdasarkan tabel diatas capaian angka phlebitis pada pasien Rawat Inap 2B mencapai 2%. dari 150 pasien yang di observasi didapatkan 3 pasien mengalami phlebitis.

Tabel 3.46 PDSA Capaian Angka Pulang atas permintaan sendiri pada Tahun 2023

Problem	Capaian angka phlebitis Desember belum mencapai target 0% yakni 2%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk Angka pulang atas permintaan sendiri
Plan	Rencana : Menurunkan capaian angka phlebitis pada pasien melalui pemasangan tanggal pada infus untuk monitoring pemasangan infus Harapan : capaian angka phlebitis dapat menurun 0% Tindakan : Monitoring dan supervisi kepatuhan kebersihan tangan, APD dan bundels phlebitis

	2. Melakukan audit terhadap hasil monitoring dan supervisi
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Pasien phlebitis di ruangan
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Capaian angka phlebitis di rawat 2B pada bulan Desember mencapai 2% angka tersebut belum mencapai target yang ditentukan 0%,
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Terjadi penurunan angka phlebitis pasien irna 2b. Seluruh petugas IRNA mampu mengkaji dan mengevaluasi terjadinya phlebitis Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Melakukan pengkajian ulang kepada pasien dan keluarga yang meminta pulang paksa sebelum mendapatkan advice pulang dengan izin dari dSepter penanggungjawab 2. Koordinasi dengan MOD 3. Evaluasi secara berkala

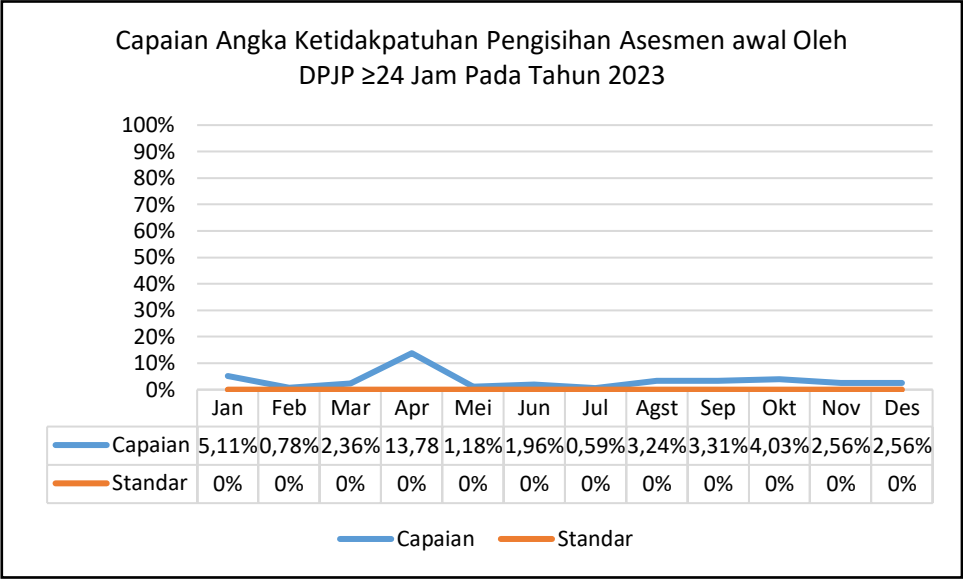
Tabel 3.47 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan kebersihan tangan	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melakukabn kebersihan tangan	Tercapainya penurunan angka phlebitis dari 4.66% menjadi < 1,5% pada bulan berikutnya	Re edukasi HH Audit secara teratur	Ka. Ruangan IPCLN Tim PPI	Satu Bulan

4. Instalasi Rawat Inap 3

Tabel 3.48 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rawat Inap 3 Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan												Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep t	Okt	No v	Des		
1	Angka Ketidakpatuhan Pengisian Asesmen awal Oleh DPJP ≥24 Jam	0%	5.11 %	0.78 %	2.36 %	13.78 %	1.18 %	1.96 %	0.59%	3.24%	3.31 %	4.03 %	2.5 6%	2.56 %	3.5%	PDSA
2	Angka ketidakpatuhan Serah Terima Pasien IGD Ke IRNA Tanpa Rekam Medis Lengkap	0%	2.8%	1.06 %	4.76 %	3.47%	1.21 %	0%	1.38%	4.81%	7.5 %	6.38 %	3,2 4%	1.19 %	2.9%	PDSA
3	Kejadian Tidak Dilakukan Penilaian NEWS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahanka n
4	Kejadian Tidak Terpasangnya Gelang Identitas Pasien	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahanka n
5	Abgka Infus Slong	0%	2.01%	1.12%	1.67%	2.12%	0.35%	1.04%	1.79%	1.69%	3.61 %	3.58 %	1,5 6%	0.60 %	1.6%	PDSA
6	Kejadian Phlebitis	≤1.5%	1.70%	0.05%	0.01%	0.75%	0.82%	0.39%	0,59%	0.84%	0.75 %	0.44 %	0,5 6%	0.30 %	0.5%	Dipertahanka n
7	Angka pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0.05%	0.01%	0%	0.01%	0.01%	0.045%	0.028%	0.00 1%	0%	0,0 1%	0.003 0%	0%	Dipertahanka n



Hasil Capaian :

- 1. Angka ketidakpatuhan pengisian assesment oleh DPJP >24 jam pada periode Juli-Desember 2023 mengalami penurunan dan kenaikan dari 0,5% di bulan Juli dan mengalami kenaikan sebesar 3,24% pada bulan Agustus dan 4.03% pada bulan Desember.
- 2. Rata-rata capaian Angka ketidakpatuhan pengisian assesment oleh DPJP >24 jam belum mencapai 0%
- 3. Masih ditemukan ketidaklengkapan assesment oleh DPJP >24 jam → penyebab DPJP tidak melakukan visite ataupun DPJP lupa tidak melengkapi assesment spesialis sewaktu visite, dan ketika libur nasional

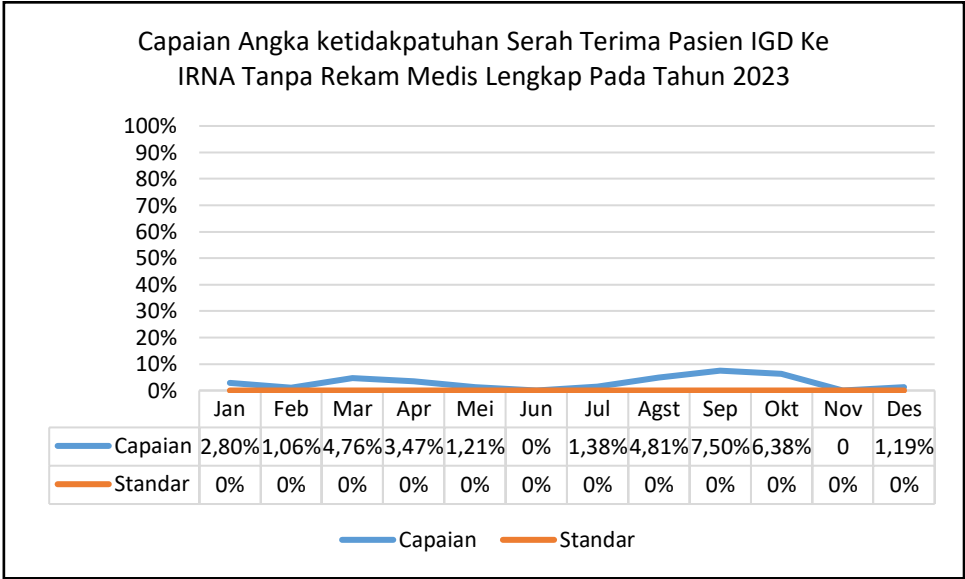
Tabel 3.50 PDSA Capaian Angka Ketidakpatuhan Pengisian Asesmen Oleh DPJP ≥24 Jam pada Bulan Desember Tahun 2023

Problem	Angka ketidakpatuhan pengisian assesment oleh DPJP >24 jam belum mencapai target 0%
Step	Menghimbau dan mengingatkan seluruh perawat rawat inap dan IGD untuk selalu melakukan crosscek ulang isi kelengkapan RM
Plan	1. Rencana : Mengetahui angka ketidakpatuhan pengisian assesment oleh DPJP >24 jam 2. Harapan : tidak ditemukan ketidakpatuhan pengisian assesment oleh DPJP >24 jam 3. Tindakan : a. Melakukan sosialisasi kepada perawat untuk mengingatkan DPJP untuk melakukan pengisian assesment terutama pasien-pasien dengan rencana KRS b. Jika DPJP tidak melengkapi assesment, perawat/pj shift/katim membantu untuk melengkapi assesment medis c. Supervisi dan evaluasi secara berkala

	3. Menginformasikan kepada Dokter spesialis yang setara (waktu memvisite pasien) dalam pengisian assesment pasien di dalam rekam medis 4. Supervisi dan evaluasi secara berkala Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Melakukan sosialisasi kepada perawat untuk mengingatkan DPJP untuk melakukan pengisian assesment terutama pasien-pasien dengan rencana KRS 2. Jika DPJP tidak melengkapi assesment, perawat/pj shift/katim membantu untuk melengkapi assesment medis 3. Supervisi dan evaluasi secara berkala
--	--

Tabel 3.47 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan kepatuhan DPJP dalam pengisian asesmen medis	Asesmen medis DPJP dapat terisi lengkap <24 jam	Tercapainya pengurangan ketidakpatuhan asesmen DPJP dari 3.30% menjadi 0% pada bulan berikutnya	Mengingatkan DPJP pada saat di ruangan dan saat rapat komite medis	Ka. Ruangan Komite medis	Satu bulan



Hasil Capaian :

- Angka kejadian ketidaklengkapan serah terima RM dari unit IGD pada bulan Juli-Desember 2023 mengalami kenaikan dari 1,30% pada bulan Juli, mengalami kenaikan sebesar 4,8% pada bulan Agustus serta mengalami kenaikan sebesar 7,50% pada bulan Desember.
- Rata-rata angka kejadian ketidaklengkapan serah terima RM dari unit IGD belum mencapai target 0%
- Masih ditemukan ketidaklengkapan serah terima RM dari unit IGD seperti,
 - Tidak lengkapnya assesment dari IGD
 - Tidak lengkapnya pengisian lembar informed consenst tindakan pasien baik pasien dengan tahap terminal atau bukan
 - Tidak lengkapnya tanda-tangan petugas IGD atau dokter IGD
 - Tidak lengkapnya informasi kondisi pasien ketika di transfer ke Unit rawat inap
 - Tidak lengkapnya berkas tilik pasien dari IGD
 - Tidak lengkapnya form NEWS dan menjelang akhir hayat

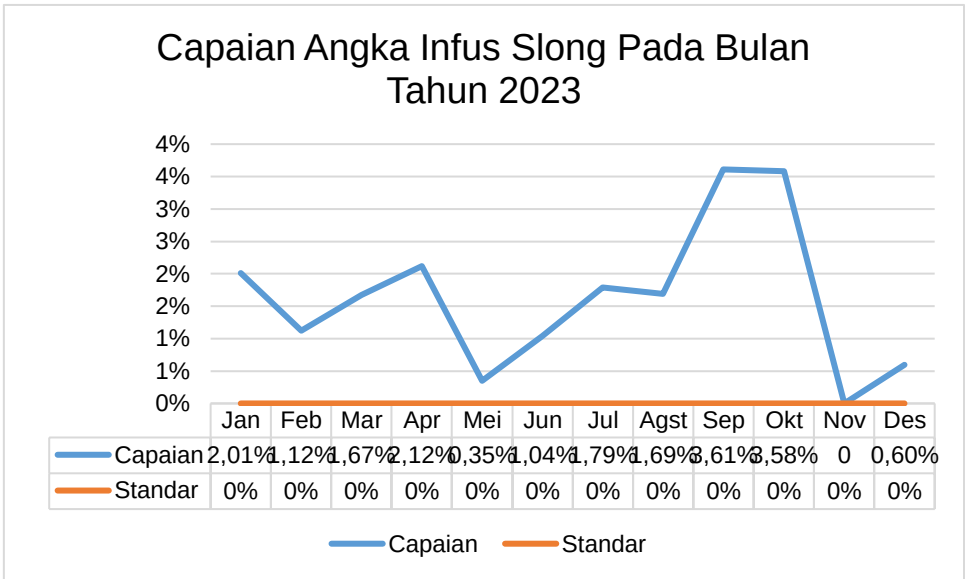
Tabel 3.53 PDSA Capaian Angka ketidakpatuhan Serah Terima Pasien IGD Ke IRNA Tanpa Rekam Medis Lengkap pada Bulan Desember Tahun 2023

Problem	Angka kejadian ketidaklengkapan serah terima RM dari unit IGD belum mencapai target 0%
----------------	--

Step	Menghimbau dan mengingatkan perawat rawat inap untuk selalu croscek ulang dan teliti mengenai ketidak lengkapan RM dari unit IGD dan menghimbau untuk perawat IGD lebih lengkap lagi dalam melakukan anamnesa dan pelengkapan isi RM
Plan	Rencana : Mengetahui jumlah presentase ketidaklengkapan serah terima RM pasien dari unit IGD dalam satu bulan yang dilakukan evaluasi secara berkala Harapan : Tidak ditemukan kejadian RM ketika serah terima pasien tidak lengkap Tindakan : - Sosialisasi kepada petugas IGD untuk mengecek kembali RM dan advice dokter/dokterspesialis sebelum memindahkan pasien ke rawat inap - Sosialisasi kepada perawat ruangan untuk selalu melakukan crosscek ulang isi RM dan advice dokter IGD/dSepter spesialis - Supervisi dan evaluasi secara berkala
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Masih ditemukan ketidaklengkapan serah terima RM dari unit IGD seperti, - Tidak lengkapnya assesment dari IGD - Tidak lengkapnya pengisian lembar informed consenst tindakan pasien baik pasien dengan tahap terminal atau bukan - Tidak lengkapnya tanda-tangan petugas IGD atau dokter IGD - Tidak lengkapnya informasi kondisi pasien ketika di transfer ke Unit rawat inap
Study	Apa yang anda pelajari ? apakah sesuai target capaian ? - Angka kejadian ketidaklengkapan serah terima RM dari unit IGD pada bulan Juli-Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,3% menjadi 7,6% - Rata-rata angka kejadian ketidaklengkapan serah terima RM dari unit IGD belum mencapai target 0% - Masih ditemukan ketidaklengkapan serah terima RM dari unit IGD (assesment IGD, lembar informed consent, TTD petugas IGD, informasi kondisi pasien)
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? - Seluruh petugas IGD atau rawat inap mampu memahami pentingnya kelengkapan RM ketika pasien ditrasnfer ke unit rawat inap beserta RM nya - Seluruh perawat IRNA mampu melakukan crosscek ulang kelengkapan RM apabila tidak lengkap maka perawat IRNA hendak melakukan koordinasi kembali dengan perawat IGD yang melakukan transfer pasien keruangan - Supervisi dan evaluasi secara berkala Follow-up dan Rencana Lanjutan - Sosialisasi kepada petugas IGD untuk mengecek kembali RM dan advice dokter/dokter spesialis sebelum memindahkan pasien ke rawat inap - Sosialisasi kepada perawat ruangan untuk selalu melakukan crosscek ulang isi RM dan advice dokter IGD/dokter spesialis - Supervisi dan evaluasi secara berkala

Tabel 3.47 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan kepatuhan petugas IGD dalam melengkapi RM saat pasien naik ke rawat inap	Menurunkan ketidaklengkapan RM pasien IGD saat naik ke rawat Inap	tercapainnya penurunan ketidakpatuhan petugas IGD dalam melengkapi RM pasien dari 4.56 % menjadi 0% pada bulan berikutnya	Koordinasi dan re-edukasi kepada seluruh petugas IGD	Ka. Ruangan Ke. Bidang yangmed Komite mutu	Satu bulan



Hasil Capaian :

- 1. Kejadian infus slong di IRNA 3 diperoleh dari bulan Juli-Desember mengalami kenaikan sebesar 1,7% pada bulan Juli dan Agustus, serta mengalami kenaikan 3,06% pada bulan Desember.
- 2. Rata-rata capaian kejadian infus slong di IRNA belum mencapai target 0% kejadian
- 3. Masih ditemukan kejadian infus slong di IRNA yang disebabkan oleh beberapa hal, penggunaan infus 100cc dengan waktu habis cepat, kurangnya pengawasan dari perawat jaga dan kurangnya pengawasan dari keluarga yang menunggu pasien

Tabel 3.56 PDSA Capaian Kejadian Infus Slong pada Bulan Desember Tahun 2023

Problem	Kejadain infus slong di IRNA belum mencapai target 0 kejadian
Step	Menghimbau dan meningkatkan seluruh petugas baik petugas jaga pershift untuk selalu memantau cairan yang terpasang pada pasien
Plan	1. Rencana : Mengetahui jumlah kejadian infus slong di IRNA baik per shift atau pehari 2. Harapan : Tidak ditemukan kejadian infus slong di IRNA 3. Tindakan : a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh petugas untuk selalu mengobservasi penggunaan cairan pada pasien b. Melakukan edukasi kepada keluarga mengenai cairan infus pasien c. Melakukan supervisi dan evaluasi berkala

	1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh petugas untuk selalu mengobservasi penggunaan cairan pada pasien 2. Melakukan edukasi kepada keluarga mengenai cairan infus pasien 3. Melakukan supervisi dan evaluasi berkala
--	--

Tabel 3.57 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan supervisi dalam pengawasan cairan infus pasien	Mengurangi angka infus slong di ruangan	Tercapainya penurunan angka infus slong dari 3.60% menjadi 0% pada bulan berikutnya	Supervisi kepatuhan petugas dalam pengecekan cairan infus secara berkala	Ka. Ruangan	Satu Bulan

5. Instalasi Care Unit

Tabel 3.58 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rawat Instalasi Care Unit pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan												Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka tidak dilakukan pengkajian dan NEWS pada pasien tahap terminal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2	Kejadian phlebitis pada pasien ICU	≤1.5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3	Kejadian kembalinya pasien ke ICU dengan kasus yang sama ≤72jam	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
4	angka tidak dilakukannya pengkajian sesuai kriteria keluar masuk ICU pada pasien ICU	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
5	Angka transfer pasien ke ICU dengan keadaan tidak stabil	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan

6. Instalasi Kamar Operasi

Tabel 3.59 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan												Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka kerusakan alat penunjang operasi	0%	0.8%	1.07 %	0.31 %	0%	0%	0%	0,78 %	0.29 %	0.27 %	0.49%	0%	0%	0,29%	PDSA
2	Angka ketidakpatuhan perawat dalam persiapan pasien operasi	0%	7.21 %	7.16 %	2.5 %	1.43 %	0%	1.26 %	2,36 %	3,54 %	0%	0%	0,45%	0%	1,78%	PDSA
3	Angka ketidaklengkapan asesmen awal pasien bedah> 24 jam sesuai kerangka waktu	≤ 20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1.54 %	0%	1.71%	1,12%	0%	0,30%	Dipertahankan

4	Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	2 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	PDSA
5	Angka ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan / penolakan tindakan	≤ 20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1.22%	0,67%	0%	0,11%	Dipertahankan
6	Kejadian ketidaklengkapan pengisian asesmen praanestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
7	Kejadian konversi regional anestesi ke general anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
8	Angka efek samping selama sedasi moderat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
9	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring status fisiologis selama anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
10	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring pemulihan pasca anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
11	Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
12	Kejadian tidak dilaksanakannya pengisian <i>surgical safety checklist</i> sesuai standart	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
13	Angka ketidaklengkapan laporan operasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1.31 %	1.74 %	0%	1.71%	0,67%	0%	0.49%	PDSA
14	Angka Infeksi Daerah Operasi	≤1,5%	0.94 %	0%	0%	0%	1.5%	0%	0,52 %	0,29 %	0%	1.71%	0,22%	0,76%	0.47%	dipertahankan

7. Maternitas

Tabel 3.63 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Maternitas pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	dipertahankan
2	Kejadian perdarahan post partu pada ibu pasca persalinan	0 Kejadian	2 kejadian	1 kejadian	2 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	PDSA
3	Kejadian partus lama pada saat ibu persalinan	0 Kejadian	0 kejadian	2 kajadian	2 kejadian	3 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	dipertahankan
4	Kejadian pre eklamsi pada ibu hamil	0 Kejadian	4 kejadian	14 kejadian	19 kejadian	5 kejadian	9 kejadian	0 kejadian	14 kejadian	PDSA
5	Kejadian infeksi nifas	0 Kejadian	2 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	2 kejadian	1 kejadian	6 kejadian	1 kejadian	PDSA
6	Kejadian keterlambatan operasi elektif	0	0 kejadian	3 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	dipertahankan

8. Perinatologi

Tabel 3.73 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Perinatologi pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka kemampuan menangani BBLR 1500gr-2500gr	≤10%	7.69%	5.40%	12.5%	9.09%	10,52%	3.70%	6.40%	Dipertahankan
2	Angka Tidak Dilakukan IMD pada bayi baru lahir	0%	0,035%	4.36%	12%	6%	8%	0%	5.07%	PDSA
3	Angka ketidaklengkapan dokumen RM pada pasien perinatologi	≤20%	20.74%	8.45%	11.15%	5.14%	6,70%	14.83%	11.17%	PDSA
4	Angka Kematian Bayi	23 / 1000 kelahiran hidup	2 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan

9. Instalasi Rawat Jalan

Tabel 3.80 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rawat Jalan pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka keterlambatan dokter spesialis di rawat jalan	≤20%	35.41%	41%	32%	38%	56,65%	56.65%	33.84%	PDSA
2	Angka ketidaklengkapan asesmen awal medis DPJP pasien rawat jalan	≤20%	18.24%	20.41%	26%	100%	24,03%	24.03%	31.45%	PDSA
3	Angka ketepatan pengisian PRMRJ	≤20%	19.24%	41.25%	100%	88%	100%	100%	74.75%	PDSA

10. Instalasi Laboratorium

Tabel 3.84 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laboratorium padaTahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Ketera ngan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka kerusakan sampel darah	<5%	0,11%	0,28%	5.07%	0.23%	0,093%	0.46%	1.06%	Diperta hankan
2	Angka kurangnya kelengkapan blanko permintaan	< 15%	9.075%	8.75%	0.09%	4.52%	6,40%	21.44 %	4.49%	Diperta hankan

	pemeriksaan/ status klinis									
3	Kejadian keterlambatan penyerahan labu darah > 2 jam	≤ 10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
4	Kejadian kesalahan penulisan hasil laboratorium ke simrs	0 kejadian	3 kejadian	4 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
5	Kejadian keterlambatan hasil laboratorium cito	<10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
6	Angka tidak terpenuhinya kebutuhan darah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
7	Angka reaksi transfuse darah	0%	0.011%	1.29%	0%	0%	0%	0%	0.26%	PDSA
8	Kejadian ketidaktepatan waktu pemeliharaan alat KSO laboratorium oleh teknisi dari vendor	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kejadian keterlambatan backup alat error (dalam waktu ≤ 24 jam)	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

11. Instalasi Radiologi

Tabel 3.88 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Radiologi pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka Ketidaklengkapan Permintaan Foto	0%	38.84%	41.23%	38.78%	35.86%	33,18%	35.12%	37.58%	PDSA
2	Angka ketidakpatuhan edukasi pemeriksaan kepada pasien sebelum dilakukan pemeriksaan radiologi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3	Angka kesalahan print hasil fot X-Ray	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
4	Angka Komplain DPJP terhadap bacaan radiologi	0%	0%	0%	0%	0.26%	0.26%	0%	0.10%	Dipertahankan
5	Angka tidak dilakukan maintenance alat setiap satu bulan sekali	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
6	Angka keterlambatan hasil bancaan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan

12. Instalasi Rekam Medis

Tabel 3.89 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rekam Medis pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka kejadian nomor rekam medis ganda	0 kejadian	6 kejadian	10 kejadian	7 kejadian	12 kejadian	9 kejadian	3 kejadian	8 kejadian	PDSA
2	Angka kejadian tidak tercetaknya SEP	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
3	Angka tidak diselesaikannya LMA (Laporan Medis Awal) dan JKK dalam kurun waktu 1x24jam	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
4	kejadian tidak bisa digunakannya surat rujukan FKTP pasien post MRS	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

5	Kejadian ketidaksesuaian identitas pasien pada surat kontrol	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Angka ketidaklengkapan pengkajian awal medis rawat inap 1x24 jam	0%	5.5%	4%	4.9%	4.8%	7%	4.4%	5.24%	PDSA
7	Angka keterlambatan pengembalian dokumen rekam medis rawat jalan >1x24 jam.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
8	Angka pengembalian RM Rawat Inap lebih dari 2 x 24 jam.	0%	77.1%	41.9%	0%	72.9%	85,8%	72.7%	55.54%	PDSA
9	Waktu penyediaan drm rawat jalan <10 menit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan

13. Instalasi Gizi

Tabel 3.117 Capaian Indikator Mutu Prioritas Instalasi Gizi Desember pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka Ketidakpatuhan Petugas Dalam Cuci Tangan	≤15%	12.5%	12.5%	15%	12.5%	10%	7.5%	12.50%	Dipertahankan
2	Angka Ketidakpatuhan Petugas Dalam Penggunaan APD	≤20%	10%	20%	10%	16.6%	16,67%	16.6%	14.65%	Dipertahankan
3	Angka Ketidakpatuhan Ahli Gizi Dalam Edukasi Pasien Tentang Diet	≤20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
4	Angka Komplain Pasien Terhadap Makanan Yang Disajikan	0%	0.033%	0.11%	0%	0%	0%	0%	0.03%	Dipertahankan
5	Angka Ketidaktepatan Waktu Distribusi Makanan Pada Pasien Rawat Inap	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
6	Sisa Makanan yang Tidak Termakan oleh Pasien	≤20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
7	Kejadian Kasalahan Pemberian Diet Pada Pasien Rawat Inap	≤10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
8	Kejadian Masuknya Benda Asing Dalam Makanan	0 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA

14. Rehabilitasi Medik

Tabel 3.118 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rehabilitasi Medik Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Kepuasan pasien dan keluarga (PMK standar pelayanan fisioterapi)	>80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kejadian kesalahan Tindakan / intervensi fisioterapi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3	Angka drop out pasien fisioterapi	<50%	7,04%	4.57%	7.36%	12.22%	10,19%	7.67%	7.80%	Dipertahankan
4	Kejadian kerusakan alat kesehatan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

15. Humas & Marketing

Tabel 3.119 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Humas & Marketing Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka Perubahan Jadwal DSepter Spesialis Di Rawat Inap	0%								PDSA
2	Angka ketidakpuasan pasien rawat jalan	0%								PDSA
3	Angka ketidakpuasan pasien rawat inap	0%								PDSA

16. Keuangan

Tabel 3.120 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keuangan Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Kejadian complain pelayanan kasir	0 kejadian								PDSA
2	Persentase pembatalan kwitansi di kasir	0%								PDSA
3	Persentase selisih uang setoran kasir dengan LHK (Laporan harian kasir)	0%								PDSA
4	Kejadian kesalahan pengiriman tagihan	0 kejadian								PDSA
5	Keterlambatan realisasi pembayaran dari rekanan	<10%								PDSA
6	Persentase piutang pasien rawat inap (bayar pribadi) bermasalah	0%								PDSA
7	Angka keterlambatan pelayanan kasir saat pelayanan >10menit	<5%								PDSA
8	Kejadian keterlambatan pelaporan rutin ke keuangan PT DPM > tgl 10 di bulan berikutnya	0 kejadian								PDSA

17. Bagian SDM

Tabel 3.121 Capaian Indikator Mutu Prioritas Bagian SDM Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka staf tidak fingerprint lebih dari 3x dalam sebulan	0%	0.039%	0.155%	0.03%	0.04%	0.15%	0.15%	0.09%	PDSA
2	angka staf terlambat lebih dari 3x dalam sebulan	0%	0.03%	0.20%	0.05%	0.20%	0.20%	0.20%	0.15%	PDSA
3	angka staf tidak mengikuti diklat internal	0%	0.1%	0.15%	0%	0.16%	0.16%	0.16%	0.12%	PDSA
4	angka staf terlambat presentasi hasil pelatihan eksternal	0%	0.5%	0%	0%	0%	0%	0%	0.08%	PDSA
5	angka staf tidak lanjut kontrak pasca masa orientasi atau dirumahkan karena legalitas	0%	0.03%	0.15%	0.03%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%	PDSA

18. Kesekretrariatan

Tabel 3.122 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Kesekretariatan Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka Keterlambatan Pengumpulan Laporan Bulanan Unit ≥ Tanggal 5	0%	0%	0%	0%	0%			0%	PDSA
2	Angka Keterlambatan Pengumpulan Laporan Bulanan Unit Ke PT ≥ Tanggal 9	0%	0%	0%	0%	0%			0%	PDSA
3	Angka Keterlambatan Rapat, Akibat Persiapan Fasilitas	0%	0%	0%	0%	0%			0%	PDSA
4	Persentase Keterlambatan Distribusi Surat Masuk	0%	0%	0%	0%	0%			0%	PDSA
5	Persentase Keterlambatan Penyelesaian Surat Keluar	0%	0%	0%	0%	0%			0%	PDSA
6	Persentase Keterlambatan Pembuatan Notulen Rapat	0%	0%	0%	0%	0%			0%	PDSA

19. Rumah Tangga

Tabel 3.123 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rumah Tangga Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka ketidakpatuhan pengunjung menggunakan kartu visitor di rawat inap	0%								PDSA
2	Angka ketidakpatuhan pengunjung membawa anak kecil (non pasien) di Rumah Sakit	0%								PDSA
3	Ketidakpatuhan dalam membersihkan ambulance setelah mengangkut pasien	0								PDSA

20. Kamar Jenazah

Tabel 3.127 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Kamar Jenazah Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Bulan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Kejadian Tertukarnya Identifikasi Jenazah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan

21. Laundry

Tabel 3.128 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laundry Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Kejadian tercampurnya linen infeksius dan non infeksius	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2	angka kehilangan linen di unit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3	Kejadian linen tercampur benda asing	0 kejadian	8 kejadian	3 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	3 kejadian	2 kejadian	3 kejadian	PDSA

22. IPSRS

Tabel 3.129 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit IPSR pada Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Kejadian AC Bocor di unit	0 kejadian	58 kejadian	59 kejadian	59 kejadian	59 kejadian	59 kejadian	0 Kejadian	59 kejadian	PDSA
2	Respon Time Genset Ketika Terjadi Pemadaman ≥10 Detik	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3	Angka keterlambatan tindakanjnt pelaporan alat rusak > 24 jam	≥80%	83.12%	71.40%	62.05%	91.23%	92.52%	0%	76.95%	PDSA
4	Kejadian tidak dilakukan kalibrasipada alat kesehatan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

23. Instalasi SIMRS

Tabel 3.133 Capaian Indikator Mutu Prioritas Instalasi SIMRS Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Ket
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka ketidakpatuhan maintenance komputer > 6 bulan sekali	0%								PDSA
2	Kejadian downtime >30 menit	0 kejadian								PDSA

24. K3RS

Tabel 3.134 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit K3RS Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Ket
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Kejadian kecelakaan kerja pada staff	0 kejadian	1 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
2	Angka ketidakpatuhan staff dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali	0%	54.87%	71.25%	71.25%	69.15%	69.15%	69.15%	67.47%	PDSA
3	Tersediannya tim penanggulangan bencana	100%	100%	100%	96.77%	96.77%	100%	100%	98.92%	Dipertahankan
4	Kejadian tercampurnya limbah infeksius & non infeksius	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

25. CSSD

Tabel 3.138 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD Pada Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-Rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka keterlambatan pengiriman instrument kotor	0%	5.33%	5.12%	29.92%	0%			13.92%	PDSA
2	Kejadian tercampurnya instrument dengan limbah	0 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	1 kejadian			1 kejadian	PDSA

26. Komite PPI

Tabel 3.138 Capaian Indikator Mutu Prioritas Komite PPI Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-Rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka Petugas Tertusuk Benda Tajam	0%	0%	0%	0%				0%	PDSA
2	Angka Ketidakpatuhan Petugas Dalam Memilah Sampah Medis Dan Non Medis	0%	0%	5%	5%				3.3%	PDSA
3	Angka Infeksi Pada Daerah Operasi	≤1.5%	1%	1.1%	0%				0.7%	PDSA
4	Angka Plebitis	≤1.5%	1%	0.8%	0.8%				0.9%	PDSA
5	Angka Infeksi Saluran Kencing	≤1.5%	0%	0%	0%				0%	PDSA

27. PKRS

Tabel 3.140 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PKRS Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-Rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka ketidakpatuhan petugas dalam pengisian SBAR	0%	50%	40%	34.45%	43%			41.86%	PDSA

2	Angka ketidakpatuhan petugas dalam memberikan edukasi kelompok	0%	16.67%	50%	42.84%	46.15%			38.92%	PDSA
3	Angka ketidaklengkapan penulisan waktu edukasi pada lembar edukasi kolaborasi	0%	46.15%	13.3%	12.1%	28.57%			25.03%	PDSA
4	Kejadian tidak dilakukannya pembinaan pada komunitas berbasis rumah sakit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian			0 kejadian	PDSA

28. Tim HIV

Tabel 3.149 Capaian Indikator Mutu Prioritas Program Nasional HIV Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Kejadian Tidak Teridentifikasi Pasien HIV Pada Pasien Bedah	0%								PDSA

29. TB DOTS

Tabel 3.150 Capaian Indikator Mutu Prioritas Program Nasional TB-DOTS Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka ketidakpatuhan pasien mengambil obat di rumah sakit	0%								PDSA
2	Kejadian Tidak Terpantaunya Pasien TB Oleh Perawat Pelaksana	0%								PDSA

30. Verifikasi

Tabel 3.151 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Verifikasi Tahun Bulan Desember 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka ketidaktepatan anamnesa dengan diagnose DPJP	0%	10.32%						10.32%	PDSA
2	Kejadian ketidaktepatan klaim >tgl 5 bulan berikutnya	0 kejadian	0 kejadian						0 kejadian	PDSA
3	Klaim pending <3%	< 3%	9.28%						9.28%	PDSA
4	Angka ketidaklengkapan berkas asuransi	0%	0%						0%	PDSA
5	Angka ketidaklengkapan	0%	0%						0%	PDSA

	pengisian formulir asuransi									
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

31. KB

Tabel 3.152 Capaian Indikator Mutu Prioritas Program Nasional KB Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka ketidakpatuhan pengisihan kartu K4 KB	0%								PDSA

32. Stunting

Tabel 3.153 Capaian Indikator Mutu Prioritas Program Nasional Stunting Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada balita	14%	1.52%	0.45%	0%	0.37%	0%	1.02%	0.56%	Pertahankan

33. Ponek

Tabel 3.154 Capaian Indikator Mutu Prioritas Program Nasional Ponek pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka Kematian Ibu	0%								PDSA
2	Kejadian Eklamsi Pada Ibu Hamil	0								PDSA
3	Kejadian Perdarahan Post Partum Pada Ibu Pasca Persalinan	0								PDSA
3	Kejadian Partus Lama Pada Ibu Saat Persalinan	0								PDSA

BAB IV

HASIL MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM MUTU LAINNYA

4.1 Program Sasaran Keselamatan Pasien

4.1.1 Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

1. Laporan Ketidaksesuaian Diagnosis Praoperasi dan Pasca Operasi Bulan Desember Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Operasi		Jumlah Ketidaksesuaian
		Elektif	Cito	
1	Januari	341	81	0
2	Februari	307	96	0
3	Maret	320	85	0
4	April	278	94	0
5	Mei	359	87	0
6	Juni	323	85	0
7	Juli	218	119	0
8	Agustus	344	92	0
9	September	366	86	0
10	Oktober	408	116	0
11	November	443	96	0
12	Desember	390	114	0

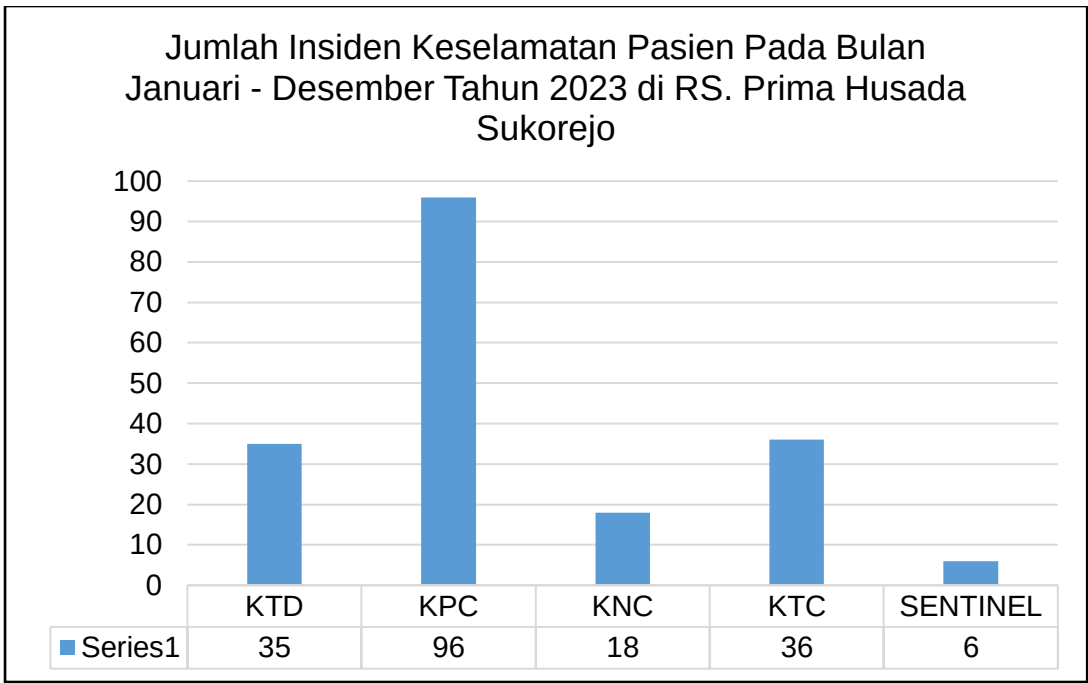
2. Kejadian Reaksi Transfusi Bulan Desember Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Transfusi	Jumlah Reaksi Transfusi
1	Januari	114	0
2	Februari	100	0
3	Maret	114	0
4	April	89	0
5	Mei	92	1
6	Juni	93	1
7	Juli	85	1
8	Agustus	68	0
9	September	68	0
10	Oktober	63	0
11	November	47	0
12	Desember	114	0

3. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) Bulan Desember Tahun 2023

No	HAIs	Desember
1	Infeksi Daerah Operasi	0%
2	Infeksi Saluran Kemih	0%
3	Phlebitis	0 %
4	VAP	0%

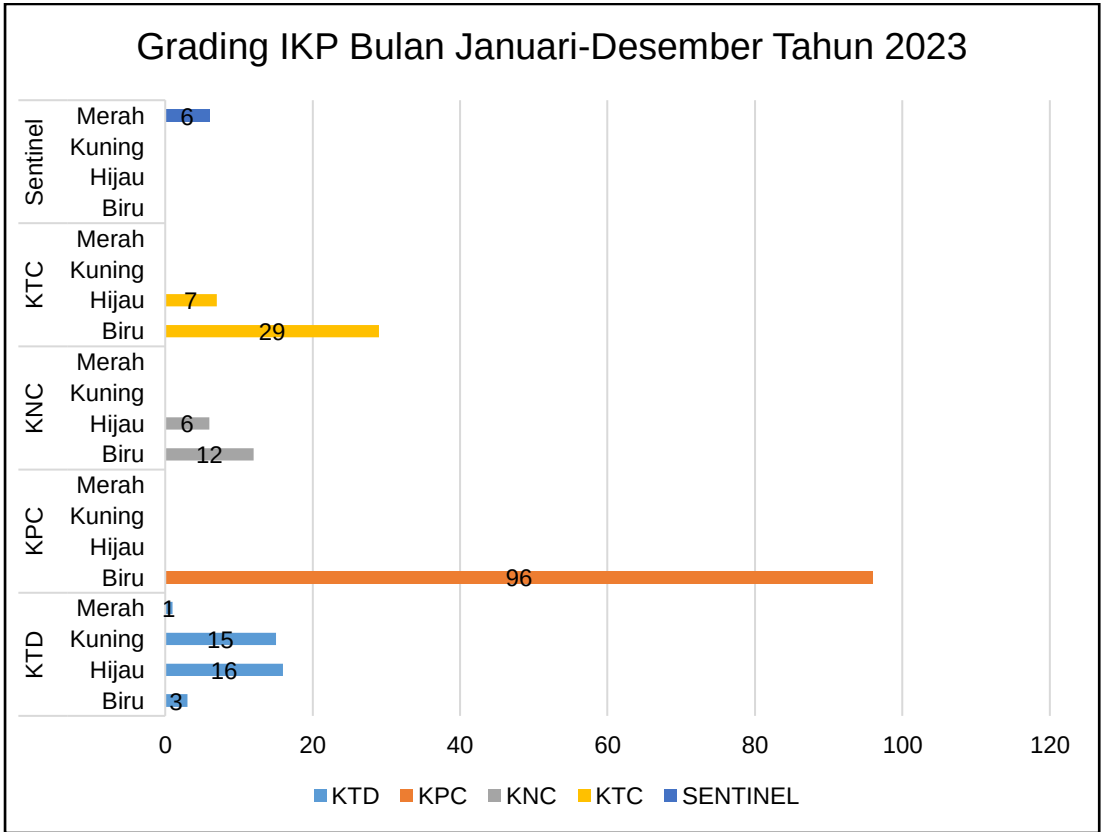
4. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) Bulan Desember Tahun 2023



Insiden keselamatan pasien adalah bentuk Insiden keselamatan pasien adalah bentuk kejadian yang berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien ketika system pemberian asuhan yang aman tidak dikelola dengan baik oleh suatu rumah sakit. Insiden keselamatan pasien dapat berupa kejadian tidak diharapkan (KTD), kejadian nyaris cedera (KNC), kejadian potensi cedera (KPC), kejadian tidak cedera (KTC), dan sentinel. Berdasarkan laporan insiden di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Bulan Desember yang dilaporkan ke tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit sejumlah 16 dan 11 insiden lainnya didapatkan melalui penarikan data pelaporan harian mutu, insiden didominasi oleh kejadian potensial cedera (KPC) sebanyak 96 insiden

Berdasarkan hasil laporan insiden ke KPPRS selama bulan Januari sampai Desember Tahun 2023, insiden keselamatan pasien yang terjadi di dominasi insiden mengenai rekam medis ganda sebanyak 74.

Berdasarkan warna gradingnya insiden yang terjadi di RS Prima Husada Sukorejo dibagi menjadi dibawah ini :



Dengan insiden yang terjadi adalah sebagai berikut :

Tabel Insiden Keselamatan Pasien Terbanyak di RS Prima Husada Sukorejo Bulan Desember Tahun 2023

No	Nama Insiden	Jumlah
1	ILO	10
2	RM Ganda	74
3	Plug pasien tidak di lepas	1
4	pemberian obat tidak sesuai jam	1
5	under diagnose	2
6	kematian bayi	3
7	Kerusakan Sampel - DL Cloting	13
8	pemberian obat tidak sesuai advice	4
9	kematian ibu	1
10	Kerusakan Sampel - KK Lisis	1
11	Pasien jatuh	3
12	ditemukan ulat pada makanan pasien	4
13	Salah dosis obat	1
14	kesalahan input di simrs	11
15	memberikan infus kepada pasien yang salah	1
16	Reaksi transfusi	3
17	Kesalahan identifikasi pada sampel	2
18	salah pemberian bayi pada bayi rawat gabung	1
19	Kesalahan pemberian obat pulang	2
20	Dressing kasa pada luka operasi tidak terpasang	1
21	luka pada bayi saat SC	2
22	Kertas picesan kada & alat steril tidak lekat	1
23	Implant orthopedi tidak di input oleh perawat	1
24	penundaan operasi	3
25	noda darah pada linen	1
26	Salah mengirimkan pasien rujukan	1
27	Cairan infus habis tidak segera diganti	1
28	Internal blanding	1
29	Salah pemberian pemeriksaan penunjang	1
30	terlambat memberi dan melaporkan advice	1
31	Pasien pulang sebelum acc dokter	1
32	Kekosongan obat	1
33	Keterlambatan DPJ > 1 jam	1
34	Suction rusak saat digunakan	1
35	Kesalahan pelaporan diagnosa pasien operasi	13
36	Pasien masih menggunakan make up saat mau OP	2
37	Salah menulis hasil lab	3
38	salah input obat	3
39	Lampu operasi tidak berfungsi ketika dipakai	1
40	Alat operasi patah ketika operasi	1
41	Salah cetak etiket pendaftaran pasien	1
42	Salah cetak etiket pendaftaran pasien	1
43	phelebitis	10



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

LEMAN
12121973 - 0045 0045 2016
887888

Jasa. Klat. P.

FORM SBAR

Situation	Masalah / gejala yang dilaporkan terkait dengan ☐ Gangguan nafas ☐ Gangguan perut ☐ Gangguan kesadaran ☒ Gangguan nyeri ☐ Gangguan kondisi kulit ☐ Gangguan pola makan ☐ Keluhan ini dimulai sejak hari dan tetap / semakin membaik / memburuk									
Background	Diagnosis Pasien saat ini : <u>Mutual apata crans @ HHT</u> Riwayat kesehatan sebelumnya : Riwayat Alergi : Tidak, Ada, sebutkan : Riwayat jatuh : Tidak, Ada, kapan : Obat-obatan yang dikonsumsi :									
Appearance	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Tanda-Tanda Vital</th> </tr> <tr> <td>TD : <u>160/10</u> mmHg</td> <td>RR : x/mnt</td> </tr> <tr> <td>Nadi : <u>80</u> x/mnt</td> <td>SpO₂ : lpm</td> </tr> <tr> <td>Suhu : <u>36</u> °C</td> <td>SpO₂ : lpm (oksigen nasal / NRBM)</td> </tr> </table> ☐ Pernafasan : Dyspnea / Kongesti / Ronkhi / Pucat / Sianosis ☐ Pencernaan : Mual / Muntah kali, deskripsi muntahan : ☐ Perubahan status kesadaran : Lupa / Tampak bingung / gelisah / lemas / ☐ Perubahan fungsi : Menurun / Membaik, dengan ☐ Perubahan pola makan : ☐ Perubahan status hidrasi : ☐ Perubahan kondisi kulit/luka : ☐ Skala nyeri : • Skor nyeri : <u>5</u> • Lokasi : <u>hati kanan</u> • Frekuensi : Hilang timbul / Konstan		Tanda-Tanda Vital		TD : <u>160/10</u> mmHg	RR : x/mnt	Nadi : <u>80</u> x/mnt	SpO ₂ : lpm	Suhu : <u>36</u> °C	SpO ₂ : lpm (oksigen nasal / NRBM)
Tanda-Tanda Vital										
TD : <u>160/10</u> mmHg	RR : x/mnt									
Nadi : <u>80</u> x/mnt	SpO ₂ : lpm									
Suhu : <u>36</u> °C	SpO ₂ : lpm (oksigen nasal / NRBM)									
Request/ Recommendation	☐ Visite oleh DPJP/ Dokter Jaga ☐ Permintaan laboratorium / Foto Rontgen berupa ☐ Perubahan terapi ☐ Cairan IV ☐ Observasi dan laporan									
Laporan ke dr. <u>Adhik</u> pada tanggal <u>1/1/24</u> jam <u>20.26</u> menggunakan telepon / WA / Langsung / Lain-lain	TTD Pemberi pesan 									
Laporan oleh <u>dmeg</u> pada tanggal <u>1/1/24</u> jam <u>20.28</u> menggunakan telepon / WA / Langsung / Lain-lain	TTD Penerima Pesan <u>Jany</u>									

gung jawab penuh diberitahukan kepada Anda tentang kondisi saat ini.



RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

RM 3.2/REV01

ERNAWATI

24021004 - 20 th 45 th 5 th

027544

Jenis Kel : P

PENGKAJIAN AWAL MEDIS BEDAH UMUM

wayat Alergi	☒ Tidak Ada	☐ Ada
mpunan	Tunggal	Pukul : WIB
amnesis	☐ Auto anamnesis	☐ Allo anamnesis

ANAMNESIS

uhan saat ini	:
wayat kesehatan	:

loanamnesis	:
-------------	---

wayat	:
-------	---

nggunaan Obat	:
---------------	---

ndisi umum	☐ Sakit Ringan	☐ Sedang	☐ Berat	☐ Sesak	GCS : 15/15
------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------

STATUS FISIK

nda Vital	TD :	Mmhg	Suhu :	°C	BB : 60 Kg
-----------	------	------	--------	----	------------

	Nadi :	X/Ml	RR :	X/M	TB : 165 Cm
--	--------	------	------	-----	-------------

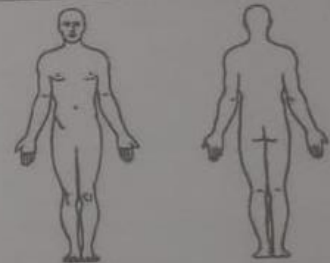
ndisi Nutrisi	☐ Obesitas	☐ Overweight	☐ Normoweight	☐ Underweight
---------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

apala / Leher	:
---------------	---

horak	:
-------	---

bdomen	:
--------	---

ktremitas	:
-----------	---



	☐ Laboratorium	:
--	---------------------------------------	---

emeriksaan	☐ Radiologi	:
------------	------------------------------------	---

enunjang	☐ Lain	:
----------	-------------------------------	---

Diagnosis medis	:
-----------------	---

Masalah	Medis	:
---------	-------	---

	Keperawatan	:
--	-------------	---

Rencana Asuhan / Terapi / Instruksi / Standing Order	:
--	---

	:
--	---

	:
--	---

Tolok ukur/ Sasaran yang akan dicapai :	nter. Skala 0
---	---------------

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Telah dilakukan edukasi tentang Pengkajian Awal Medis Bedah Umum kepada :	Pasien	Keluarga	Dokter
☒ Pasien			
☒ Keluarga pasien, nama :			
Hubungan dengan pasien :			
☒ Tidak dapat memberi edukasi kepada pasien atau keluarga Karena :	(Ernawati)	()	()



FORM SBAR

Situation	Masalah / gejala yang dilaporkan terkait dengan ☐ Gangguan nafas ☐ Gangguan perut ☐ Gangguan kesadaran ☐ Gangguan nyeri ☐ Gangguan kondisi kulit ☐ Gangguan pola makan ☒ <i>keperawatan</i> Keluhan ini dimulai sejak <i>2 jam x 4</i> dan tetap / semakin membaik / memburuk									
Background	Diagnosis Pasien saat ini : <i>Hematemesis</i> Riwayat kesehatan sebelumnya : Riwayat Alergi : Tidak, Ada, sebutkan : Riwayat jatuh : Tidak, Ada, kapan : Obat-obatan yang dikonsumsi :									
Appearance	<table><tr><td colspan="2">Tanda-Tanda Vital</td></tr><tr><td>TD : <i>140/90</i> mmHg</td><td>RR : <i>22</i> x/mnt</td></tr><tr><td>Nadi : <i>96</i> x/mnt</td><td>SpO₂ : <i>95</i> lpm</td></tr><tr><td>Suhu : <i>36</i> °C</td><td>SpO₂ : lpm (oksigen nasal / NRBM)</td></tr></table> ☐ Pernafasan : Dyspnea / Kongesti / Ronkhi / Pucat / Sianosis ☐ Pencernaan : Mual / Muntah kali, deskripsi muntahan : ☐ Perubahan status kesadaran : Lupa / Tampak bingung / gelisah / lemas / ☐ Perubahan fungsi : Menurun / Membaik, dengan : ☐ Perubahan pola makan : ☐ Perubahan status hidrasi : ☐ Perubahan kondisi kulit/luka : ☒ Skala nyeri : • Skor nyeri : <i>4</i> • Lokasi : <i>ultra</i> • Frekuensi : Hilang timbul / Konstan		Tanda-Tanda Vital		TD : <i>140/90</i> mmHg	RR : <i>22</i> x/mnt	Nadi : <i>96</i> x/mnt	SpO ₂ : <i>95</i> lpm	Suhu : <i>36</i> °C	SpO ₂ : lpm (oksigen nasal / NRBM)
Tanda-Tanda Vital										
TD : <i>140/90</i> mmHg	RR : <i>22</i> x/mnt									
Nadi : <i>96</i> x/mnt	SpO ₂ : <i>95</i> lpm									
Suhu : <i>36</i> °C	SpO ₂ : lpm (oksigen nasal / NRBM)									
Request/ Recommendation	☐ Visite oleh DPJP/ Dokter Jaga ☐ Permintaan laboratorium / Foto Rontgen berupa : ☐ Perubahan terapi : ☐ Cairan IV : ☐ Observasi dan lapor									
Dilaporkan ke dr. <i>Novik Sp.P</i> pada tanggal <i>11/1/24</i> jam menggunakan telepon / WA/ Langsung / Lain-lain		TTD Pemberi pesan <i>[Signature]</i>								
Respons oleh <i>dr. Andika Hidayat</i> pada tanggal <i>11/1/24</i> jam menggunakan telepon / WA/ Langsung / Lain-lain dvis baru : <i>GAT stop sementara</i>		TTD Penerima Pesan <i>dr. Andika Hidayat</i>								
Mengandung jawab penuh dibentahukan kepada Anda tentang kondisi saat ini.										

CHECKLIST ORIENTASI RUANG RAWAT INAP

amar :

/ Jam :

n : PJS kepatan

	Ya	Tidak
arawat penerima pasien memperkenalkan diri		
identifikasi pasien dan menjelaskan tujuan identifikasi pasien		
orientasi ruangan rawat:		
• Nurse callsystem		
• Tempat makan dan minum		
• Jam kunjungan keluarga (kartu penunggu)		
• Fasilitas toilet (menggunakan air hangat, air dingin)		
• Penggunaan remote televisi dan AC		
• Penekan semua item yang ada di GC (General Consent)		
• Cara mencuci tangan		
• Penyimpanan makanan untuk keluarga		
• Asuhan – asuhan pasien (DPJP, gizi, apoteker)		
• Etika batuk		
• Buang sampah		
• Penyimpanan makanan untuk keluarga		
• Tata cara pengaduan pelayanan		
• Second opinion		
• Larangan mambawa makan dari luar untuk pasien		
atan penting:		

kan tanda (V) pada kolom diatas

ruan,

Perawat/ Bidan

Pasien / Keluarga

(.....)

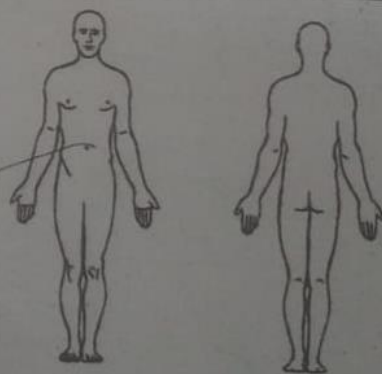
(.....)

il MasukRS : 21/12/2023

DPJP Utama

dr.

PENGKAJIAN AWAL MEDIS PENYAKIT DALAM

Gejala Alergi	☐ Tidak Ada	☐ Ada
Gejala Infeksi	Tanggal :	Pukul : WIB
Anamnesis	☐ Auto anamnesis	☐ Allo anamnesis
Gejala saat ini	ANAMNESIS	
Gejala kesehatan	menitir bahu menitir bahu, kepala & ~ ~ ~	
Anamnesis		
Gejala Penggunaan Obat		
Gejala umum	☐ Sakit Ringan ☒ Sedang ☐ Berat ☐ Sesak GCS :	
Gejala Vital	STATUS FISIK	
Gejala Nutrisi	TD : 0 MmHg	Suhu : 36.5 °C
Gejala Jantung / Leher	Nadi : 0 X/Mt	RR : 20 X/M
Gejala Jantung / Leher	☐ Obesitas ☐ Overweight ☒ Normoweight ☐ Underweight	BB : Kg TB : Cm
Gejala Jantung / Leher	~ ~ ~ ~ ~	
Gejala Jantung / Leher		
Gejala Jantung / Leher	☐ Laboratorium : 01 07/01 2015 ☐ Radiologi : ☐ Lain :	
Gejala Jantung / Leher	menitir bahu - kepala ~ ~	
Gejala Jantung / Leher	Medis : Keperawatan :	



PENGKAJIAN RISIKO JATUH PASIEN DEWASA
(DEWASA (MORSE FALSE SCALE))

Kategori Risiko	Status	Skor	Kapan Agam	Kapan Ulang	Tanggal
Diagnosis Kunder (Diagnosis dial)	Ya	15	1/24	2/24	
	Tidak	0	0	0	
Ya Berjalan (mobilitas)	Tengganggu / Tidak Normal / Pincang / Diseret	20		0	
	Lemah / Tidak Bertenaga	10			
	Normal / Tidak Dapat Bergerak Sendiri / Bedrest (tirah baring)	0	0	0	
Indisi Mental	Tidak Menyadari Alas Keterbatasan Yang Dimiliki	15			
	Sadar Akan Kemampuan Diri Sendiri	0	0	0	
Al Bantu (tongkat)	Berjalan dengan berpegangan pada furniture	30			
	Berjalan dengan penopang (tongkat, kursi roda, manusia)	15			
	Berjalan normal / Tidak menggunakan alat bantu	0	0	0	
Memasang Infus	Ya				
	Tidak	20			
Gejala Jatuh	Ya	0	20	20	
	Tidak	25			
	Total	0	0	0	
Langkah-Langkah Intervensi (Berilah tanda centang pada intervensi yang telah dilakukan)					
RENDAH 0-24	1. Lakukan orientasi lingkungan dan kegiatan rutin rumah sakit : letak kamar mandi, nurse station, stop kontak, bel pasien dll		✓	✓	
	2. Lakukan kolaborasi multi disiplin dalam perencanaan perawatan risiko jatuh		✓		
	3. Lakukan edukasi pencegahan jatuh kepada pasien dan keluarga		✓	✓	
	4. Pastikan ruangan dan kamar mandi selalu rapi dan kering		✓		
	5. Tempatkan benda-benda pribadi dalam jangkauan pasien		✓		
	6. Pastikan alat bantu dengan atau kaca mata ada di dekat pasien dan berfungsi (bagi yang menggunakan alat tersebut)		✓	✓	
	7. Posisikan tempat tidur pasien berada dalam posisi rendah dengan rem dan handrail dalam posisi terkunci		✓	✓	
	8. Pastikan jalan ke kamar mandi bebas hambatan dan terang		✓		
	9. Pertimbangkan menempatkan dekat kamar mandi bagi pasien yang sering ke kamar mandi		✓		
	10. Letakkan alat bantu mobilitasi dekat dengan pasien (tongkat, walker, tripod dll)		✓	✓	
	11. Diskusikan status risiko jatuh pasien pada setiap pergantian shift		✓	✓	
	12. Lakukan pengawasan pada pasien yang menggunakan obat yang menimbulkan risiko jatuh		✓	✓	
	13. Lakukan evaluasi pada status mental pasien		✓	✓	
	14. Gunakan sandal anti slip		✓	✓	
	15. Bantu pasien ke WC/ penggunaan pispor		✓	✓	
SEDANG 25-44	Semua hal yang diatas, ditambah :		✓		
	1. Sedakan urineir dekat pasien		✓		
	2. Konsultasi fisioterapi bila perlu		✓		
	3. Pasang stiker kuning pada gelang pasien		✓		
TINGGI ≥ 45	Semua hal yang diatas, ditambah :		✓		
	1. Letakkan tempat tidur pasien dekat dengan nurse station		✓		
	2. Libatkan keluarga dalam monitoring		✓		
	3. Kunjungi dan monitor pasien setiap jam		✓		
	4. Jangan tinggalkan pasien tanpa pengawasan di kamar mandi atau mobilitasi		✓		
	Total Skor	0-20	0	0	
	Kesimpulan	rendah			
	Nama Dan Tanda Tangan Yang Melakukan Penilaian	ayu		af	

Pemeriksaan Penunjang		
Laboratorium	Radiologi	Pemeriksaan lainnya
DL, GDA, DPT, JE		ECG
Diagnosis		
Diagnosis awal	Dss cam Pukuk + Dhrh	
Diagnosis banding		
Permasalahan		
Medis	Dss cam	
Keperawatan	Defisit volume cairan.	
Rencana Asuhan (Tetapi / Instruksi / Standing Order / Intervensi)		
Ukr 1/1 - 1/1 long ddu c/3 & mny cont 1/1 g an 2x4y g an 2x4y g an 2x4y g an 2x4y		
Tolok ukur/ Sasaran yang akan dicapai: Volume cairan keperawatan		
Ringkasan Pulang (Kondisi kesehatan pasien saat akan keluar IGD)		
Keadaan Umum	(baik)	
Vital Sign	TD : 120/80 mmHg Nadi : 80 x/mnt Suhu : 36 °C RR : 20 x/mnt	
Kondisi saat keluar	Tanggal : 1/1/2024 Pukul : 23.30 WIB ☒ Membaik ☐ Tidak Ada Perbaikan	
Tindak Lanjut		
☐ Pulang Atas Permintaan Sendiri alasan ☐ Ekonomi ☐ Jarak RS ☐ Alasan Pribadi ☐ Pengobatan Alternatif ☐ Lain-lain ☐ Pulang Atas Persetujuan ☐ Kontrol tanggal : Ke IGD/ Poli ☐ Dirujuk ke ☒ Rawat inap, indikasi : Dss cam ☐ Preventif ☒ Kuratif ☐ Rehabilitatif ☐ Paliatif ☐ Khusus/Specialistik ☐ Intensif ☐ Operasi, indikasi : ☐ Meninggal pukul WIB		
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
Telah dilakukan edukasi tentang Pengkajian Awal Medis Gawat Darurat kepada		
☐ Pasien	Pasien	Keluarga
☐ Keluarga pasien, nama		
Hubungan dengan pasien		
☐ Tidak dapat memberi edukasi kepada pasien atau keluarga		
Karena		

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

- Skala nyeri _____
 Lokasi nyeri _____
 Frekuensi nyeri ☐ Jarang ☐ Hilang timbul ☐ Terus menerus
 Lama nyeri _____
 Merajal ☐ Tidak ☐ Iya
 Kualitas nyeri ☐ Nyeri Tumpul ☐ Nyeri tajam
☐ Panas/terbakar

Faktor pemicu/memperberat

No	Kriteria Barthel Index	Dengan Bantuan	Mandiri	SKOR
1	Makan	5	10	5
2	Aktifitas toilet	5	10	5
3	Berpindah dari kursi roda ke tempat tidur/ sebaliknya, termasuk duduk di tempat tidur	5-10	15	10
4	Kebersihan diri mencuci muka menyisir rambut menggosok gigi	0	5	5
5	Mandi	0	5	5
6	Berjalan di permukaan datar	10	15	10
7	Naik turun tangga	5	10	5
8	Berpakaian	5	10	10
9	Mengontrol defekasi	5	10	10
10	Mengontrol berkemih	5	10	10
Total skor				70

Ket : 0-80 : ketergantungan berat, 91-99 : ketergantungan ringan, 100 : mandiri

1. Apakah pasien menggunakan kursi roda atau membutuhkan bantuan?
☒ Ya ☐ Tidak
2. Apakah ada inkontinensia uri atau alvi?
☐ Ya ☒ Tidak
3. Apakah ada riwayat dekubitus atau luka dekubitus?
☐ Ya ☒ Tidak
4. Apakah pasien diatas 65 tahun?
☐ Ya ☒ Tidak

Khusus Anak

Apakah ekstremitas dan badan tidak sesuai dengan usia perkembangan? ☐ Ya ☐ Tidak

Apabila salah satu jawaban adalah "Ya", maka lakukan edukasi pencegahan dekubitus : ☐ sudah ☐ belum



PENGKAJIAN RISIKO JATUH PASIEN DEWASA
(MORSE FALL SCALE)

Item / Risiko	Skala	R skor	Raport R skor	Raport Ulang Tanggal
Status Sirkulasi (diagnosis Maks)	Ya	15	2 / 1/21	
	Tidak	0		
Gaya Berjalan (ambulasi)	Terganggu / Tidak Normal / Pincang / Diseret	20	10	
	Lemah / Tidak Bertenaga	10		
	Normal / Tidak Dapat Bergerak Sendiri / Bedrest (tirah baring)	0		
Kondisi Mental	Tidak Menyadari Atas Keterbatasan Yang Dimiliki	15	0	
	Sadar Akan Kemampuan Diri Sendiri	0		
Alat Bantu (Tongkat)	Berjalan dengan berpegangan pada furniture	30	10	
	Berjalan dengan penopang (tongkat, kursi roda, manusia)	15		
	Berjalan normal / Tidak menggunakan alat bantu	0		
	Ya	20		
Terpasang Infus	Tidak	0	20	
Risiko Jatuh	Ya	25	0	
	Tidak	0		
Total		0	40	

Langkah-Langkah Intervensi (Berilah tanda centang pada intervensi yang telah dilakukan)

RENDAH
6-24

SEDANG
25-44

TINGGI
45

1. Lakukan orientasi lingkungan dan kegiatan rutin
rumah sakit : letak kamar mandi, nurse station,
stop kontak, bel pasien dll
2. Lakukan kolaborasi multi disiplin dalam
perencanaan perawatan risiko jatuh
3. Lakukan edukasi pencegahan jatuh kepada
pasien dan keluarga
4. Pastikan ruangan dan kamar mandi selalu rapi
dan kering
5. Tempatkan benda-benda pribadi dalam
jangkauan pasien
6. Pastikan alat bantu dengan atau kaca mata ada di
dekat pasien dan berfungsi (bagi yang
menggunakan alat tersebut)
7. Posisikan tempat tidur pasien berada dalam
posisi rendah dengan rem dan handrail dalam
posisi terkunci
8. Pastikan jalan ke kamar mandi bebas hambatan
dan terang
9. Pertimbangkan menempatkan dekat kamar mandi
bagi pasien yang sering ke kamar mandi
10. Letakkan alat bantu mobilitasi dekat dengan
pasien (tongkat, walker, tripod dll)
11. Diskusikan status risiko jatuh pasien pada setiap
pergantian shift
12. Lakukan pengawasan pada pasien yang
menggunakan obal yang menimbulkan risiko
jatuh
13. Lakukan evaluasi pada status mental pasien
14. Gunakan sandal anti slip
15. Bantu pasien ke WC/ penggunaan pispor
- Semua hal yang diatas ditambah :
1. Sedakan urinoir dekat pasien
2. Konsultasi fisioterapi bila perlu
3. Pasang stiker kuning pada gelang pasien
4. Pasang tanda risiko jatuh pada tempat tidur
pasien
- Semua hal yang diatas ditambah :
1. Letakkan tempat tidur pasien dekat dengan nurse
station
2. Libatkan keluarga dalam monitoring
3. Kunjungi dan monitor pasien setiap jam
4. Jangan tinggalkan pasien tanpa pengawasan di
kamar mandi atau mobilitasi

Total Skor
Kesimpulan
Nama Dan Tanda Tangan Yang Melakukan
Penilaian



RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

RM 3.4/REV01

ARIFIN
04/12/1970 - 53 th 0 bnt 23 hr
087456

Jns. Kel : L

PENGKAJIAN AWAL MEDIS NEUROLOGI

Riwayat alergi	☐ Tidak Ada	☐ Ada
Kunjungan	Tanggal 19/12/2023	Pukul 16 WIB
Anamnesis	☐ Auto anamnesis	☐ Allo anamnesis

ANAMNESIS

Keluhan saat ini
Riwayat kesehatan

Handwritten notes in the Anamnesis section.

Alloanamnesis

Riwayat
Penggunaan Obat

Kondisi umum

☐ Sakit Ringan ☐ Sedang ☐ Berat ☐ Sesak

GCS

STATUS FISIK

Tanda vital TD : 120 mmHg Nadi : 80 x/menit Suhu : 36.5 °C RR : 20 x/menit BB : 65 kg TB : 165 cm

Kondisi nutrisi ☐ Obesitas ☐ Overweight ☐ Normoweight ☐ Underweight

Kepala / Leher

Thorak

Abdomen

Ektremitas

Status Neurologis

Pemeriksaan
penunjang

☐ Laboratorium
☐ Radiologi
☐ Lain

Diagnosis medis

Masalah

Medis
Keperawatan

Rencana Asuhan / Terapi / Instruksi / Standing Order

Handwritten notes in the Rencana Asuhan section.

Tolok ukur/ Sasaran yang akan dicapai :

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

telah dilakukan edukasi tentang
Pengkajian Awal Medis Neurologi kepada :

Pasien
Keluarga pasien, nama :
Hubungan dengan pasien :
Tidak dapat memberi edukasi kepada pasien atau keluarga
Karena :

Pasien

Keluarga

Dokter

Signature and stamp of the doctor.



RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

RM 6.2

ARIFIN
04/12/1970 - 53 th 0 bta 23 hr
057455

Jns. Kol : L

FORM SBAR

S	Situation	Masalah / gejala yang dilaporkan terkait dengan ☐ Gangguan nafas ☐ Gangguan perut ☒ Gangguan kesadaran ☐ Gangguan nyeri ☐ Gangguan kondisi kulit ☐ Gangguan pola makan ☐ Keluhan ini dimulai sejak kemarin pagi dan tetap / semakin membaik / memburuk									
B	Background	Diagnosis Pasien saat ini : <u>POC ec sup. cnp. unfr</u> Riwayat kesehatan sebelumnya : Riwayat Alergi : <u>Tidak</u> Ada, sebutkan : Riwayat jatuh : <u>Tidak</u> Ada, kapan : Obat-obatan yang dikonsumsi :									
A	Appearance	<table><tr><td colspan="2">Tanda-Tanda Vital</td></tr><tr><td>TD : <u>90/60</u> mmHg</td><td>RR : <u>24</u> x/mnt</td></tr><tr><td>Nadi : <u>115</u> x/mnt</td><td>SpO₂ : <u>95</u> lpm</td></tr><tr><td>Suhu : <u>37</u> °C</td><td>SpO₂ : lpm (oksigen nasal / NRBM)</td></tr></table> ☐ Pernafasan : Dyspnea / Kongesti / Ronkhi / Pucat / Sianosis ☐ Pencernaan : Mual / Muntah kali, deskripsi muntahan : ☒ Perubahan status kesadaran : Lupa / Tampak bingung / gelisah / lemas / ☐ Perubahan fungsi : Menurun / Membaik, dengan ☐ Perubahan pola makan : ☐ Perubahan status hidrasi : ☐ Perubahan kondisi kulit/luka : ☐ Skala nyeri : • Skor nyeri : • Lokasi : • Frekuensi : Hilang timbul / Konstan		Tanda-Tanda Vital		TD : <u>90/60</u> mmHg	RR : <u>24</u> x/mnt	Nadi : <u>115</u> x/mnt	SpO ₂ : <u>95</u> lpm	Suhu : <u>37</u> °C	SpO ₂ : lpm (oksigen nasal / NRBM)
Tanda-Tanda Vital											
TD : <u>90/60</u> mmHg	RR : <u>24</u> x/mnt										
Nadi : <u>115</u> x/mnt	SpO ₂ : <u>95</u> lpm										
Suhu : <u>37</u> °C	SpO ₂ : lpm (oksigen nasal / NRBM)										
R	Request/ Recommendation	☐ Visite oleh DPJP/ Dokter Jaga ☐ Permintaan laboratorium / Foto Rontgen berupa ☐ Perubahan terapi ☒ Cairan IV : <u>NS</u> ☐ Observasi dan lapor									
Dilaporkan ke dr. <u>Novita Maulidiyah</u> pada tanggal <u>29.11.2020</u> jam menggunakan telepon <u>WA</u> / Langsung / Lain-lain		TTD Pemberi pesan <u>dr. Novita Maulidiyah, Sp.P</u> <u>46/SIP-DS/29/424.072/2020</u>									
Respons oleh <u>dr. Khairul Wafa Musthofa</u> pada tanggal <u>29.11.2020</u> jam <u>03:43</u> menggunakan telepon <u>WA</u> / Langsung / Lain-lain		TTD Penerima Pesan <u>dr. Khairul Wafa Musthofa</u> <u>46/SIP-DS/29/424.072/2020</u>									
Advis baru : <u>Ceftriaxone 2x1</u> <u>Nebul Combiven / 8 jam</u> <u>Non ISO</u> Tanggung jawab penuh dibentahukan kepada Anda tentang kondisi saat ini.											